

先哲医话

浅田宗伯

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
序	5
张序	6
卷上	7
卷下	49
黄跋	82
书《先哲医话》后	83

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

序

栗园浅田君以廓清吾道为己任，其撰着布世。顷又聚亨元以降哲匠之论医者，删定其文，名曰《先哲医话》。余受而读之，艮山先生以下凡十三家，其超迈之识，独得之见，发前贤所未发，而于诊候施設之法，的实明确。寓妙用于片言，寄活变于只句，可谓医林圭臬也。今夫稗说野乘所载古昔英雄之战略，有神算可骇者，有勇敢可畏者，有运用转化不可测者，然以冗杂无统，人或漫然不省记。一入良史笔，则耳目一新，永为百世模范矣。斯编原以国字书之，多出门人手，故俚言俗语间失浅易，读者嫌焉。今经君删润，而文理烁然，神机活动，如读史臣所记良将战策，使人跃然兴起，君不特医林韩白，殆亦方家马班也。嗟夫！庸陋无识辈，炫奇斗异，辩给欺俗，苟以自售，此吾道之所以日萎HT不振也。则凡言之裨益治术，发挥真理者，虽出今人，亦宜记以广其传也。况先哲之遗范，垂法百世者耶。昔人有观楚汉战处，而叹时无英雄者，盖假刘项慨当时耳。使斯编所载诸豪俊出，今日则必将有雄论快辩，起吾道之衰者焉。是盖君撰述之意，余亦有感于此也久矣。及其命序，乃不辞而书。

庆应二年丙寅三月笠间侍医棚谷善撰

张序

予既序《皇国名医传》一书，而知扶桑国里亦有杏林。若木华中岂无橘井，宜乎视祖州为仙岛，而化海峤作神山也。然只详其姓氏里居，师徒授受，与夫活国活人之事，而于孙思邈龙宫秘诀，未勒成篇，抱朴子金匱神方，未纂入册，徒令后之人流连往昔，景仰遗徽，有华陀不在之叹焉。今年夏季，幕中西席施君邦孚，因不习水土，兼失调摄。陡患臌胀，势已增剧，遂延浅田君来视。察脉投剂，不三四服，而泽腹之坚，顿如桶底之脱，病遂霍然。始知扁鹊来齐，治腠理之甚易，太仓在汉，解颅脑而何难，真三折肱而九折臂矣。日者复携《先哲医话》一书来求序于予，翻阅数过，见某氏治某病，察某候，用某药，议论精卓，剖晰详明，医固井井而有条，事亦凿凿之可据。乃知太上玉经之说，犹传诸王君，隐仙灵宝之方，堪师夫禄里，则是书之成，洵后学之津梁，医家之圭臬也。因志数言于简端云。

大清光绪四年戊寅仲冬钦差大臣四明张斯桂撰并书

卷上

余少年读先哲理书，窃谓不粗卤则过密，与己所见不合，故不终卷而已。因取仲师之经，一意攻之，略窥述作之旨，又质之于治术。数十年，而后阅诸家之书，始知先哲独至之本领，悔当日不虚心凝思。从此寻绎，则至古人域亦不难也。惜乎日暮路远，不复能与之相上下，以成一家。然亦不能自止，姑录其一二，以为后生解悟之资云。

卷上

后藤艮山

近世古方之学，以名古屋玄医并河天民为翹楚，而未免金元陋习。至艮山先生，豪然崛起，一洗从前弊风。其识见理疗，必当有迥异乎先辈者，世以为好奇非矣。盖吾医术至一溪道三氏之门，流碎残极矣。是以享元医人复转而古，此亦自然之势也。(拙轩曰：一部伤风约言，翁之本领在此，可谓善读《伤寒论》者。后来豪杰辈出，皆闻翁之风而兴起者，斯为吾道中兴。先生起笔，兹非偶然也。)谷肉果菜者，正性也。草木虫石者，偏性也。故古昔养精以正性者，治病以偏性者。后人不知此义，拟以药品补精气，盖亦误矣。(《素问》云：五谷为养，五果为助，五菜为充，毒药攻邪，此即医家大纲领。先生早标揭焉，而为他日东洞诸辈立论之蓝本。)乱世人其气剽悍，肝胆气郁少。治世人其气游惰，肝胆气郁多。故宜以熊胆开其郁，令肝胆气达。(永富凤曰：余征之于都邑市朝之人，比比皆然。盖太平日久，五民蕃息，金钱虚耗，奢侈日盛，则知巧之民不免病气势也。医人施治之日从这处下工夫，则有大裨益矣。)其人有

癖而饮食减少者，譬之于人家犹廊颓厢敝，而堂室渐狭小也。故不去癖，则胃不能振。医不知此理，欲与毒药补胃气，且菲饮食，益损精液者，不亦谬乎。凡疗此症，先驱癖，以滋味养胃气为主也。痈疽饵食鸡肉或鸡卵，能托出其毒。优于参，故治疮以饵食为专一也。(徐灵胎曰：服药原为治病而设，并非借以生长气血也。殆是同一见。)外感以汤液为主，内伤以饵食为主，错之则不得其治也。

赤蛙不止治小儿痢，亦治大人痢，盖痢痢皆属癖也。此品能治癖气，妨害脾胃为下利者，兼制蛔虫。(杨氏直指曾氏口议并云：十五以下为痞，十五以上为瘵，颇与此说合。而二氏徒用固阳滋阴之剂，更无发明。艮山特用血荡气之药，以除腹里之癖，其术高一等。)痢利者，饵鳊鲠以炙干为可。

按腹自心下至脐，任脉突起者，病聚脉下故也。病不聚者，脉不必突起。老人肉脱发此证者，为近死期。

按腹心下任脉左右充满有力者为实，若濡弱不充满者属虚也。

虚惫症，唇色不淡白。耳叶未萎者，可救活也。是宜熟察。

阳气浮泛者，难认肉脱之候。先诊背部，其人每咳或喘，背上陷下者，因气逆见脱肉之痕也。此证属气胀，故名曰虚浮，不必水气也。

诊病患宜先审问曾患霉毒否，何则？今世霉毒浸淫筋骨，多元气为之壅塞者也。

病至大患目不瞬者，眼胞元气脱也。乃为反目，兆近死期。

诸病以渐成者多难治，若肉脱或有水气者不治。

凡有痛者，脉多紧弦，如太阳病头痛者是也。动与紧似相反，而紧弦者，动之甚也。动脉变迟者，正气弛而邪气未除也，如结胸脉迟是也。盖动变迟者可救，不变而数者殆。

黄胆未发前为腹痛者，多是属癖，又有脾脏郁结为腹痛者可辨别。（《金匱》云：谷气不消，胃中苦浊，此所以湿热为腹痛。又云：诸黄腹痛而呕者，宜柴胡汤。此系黄胆腹痛治法。）囁噎一旦食进者，不可恣吃，其人原胃中虚竭，反招害。

卒中风，多系癖塞心，故人事不省，不能活。若不塞心者，半身不遂，或口眼斜耳。其虽人事不省，而六脉相应，手足厥冷者，一身大气犹存，可救也。

男女俱年未壮而身不了了者，多系风寒，宜调护。若缓漫经日，则大便溏，以至重症，故此证大便秘结为佳，溏泄为恶。

专发声音者多吐血，而脉不数，是不足畏。真吐血者，其脉必数急，是大可恐。

凡病不论六淫七情饮食男女，皆因一元气郁滞。故皮肤郁者，经络滞者，遂皆及腹里，犹水之湊陷地，医者先得其大纲治之为要。

霉毒沉滞骨节者，经络壅塞尤甚，故发种种变证。不可不知。

其人虚弱咳嗽久不止者，此由寒气壅表，与虚火扇肺，故咳愈甚，而肺益涸。

奔豚证有肝气兼霉毒者，有肝气带疝者，但霉毒与疝不为奔豚。古语云：诸风掉眩属肝是也。

痉及痲之类，身体不自由者，苟健啖不运动，则脾气不能行，故四五年后必死。患此证者，宜务运动，以行脾气，庶几终其天年。名古屋玄医曾患之，善全其终，可

以证焉。

水肿咳嗽甚者，必水气辐凑上部。又水气发暴咳者，为濒死。

杂病饥而不能食者有二道：其人虽饥，闻食臭忽恶之者，虫也；但饥而不能食者，瘕也。

痿与痺易混，而详之，则痺者，主皮肤不仁；痿者，主筋骨萎软。

风邪难愈，或虽瘥复发者，不必服风药，唯以助阳气散风邪为要。

病阳虚者易治，阴虚者难治，何者？阴虚则阳益虚，如虚劳是也。故阴虚火动者，虽能食遂至死。阳虚者，脉不数而食减，是以多肉脱。故主饵食，禁灸。灸之则反脉为数，其为害亦不鲜矣。

虚劳脉细数者，脉乍见和平，则为近死期。易所谓枯杨生华，何可久也？虽缓者，不出五七日而死。

一夫病似狂，恐惧恶见人，闭居陋室半年所，后神气渐爽，而手足拘挛，舌强直难语言，心下如板筑，瘕妨胀。因灸脊际，服熊胆，病颇愈。盖此证瘕气妨胀，故不发狂。若瘕气内攻，则精神失职，必发狂。今不然，故免此患也。

妇人脐下及任脉有块者，不孕。凡瘕所在，阳气必不行，故以艾灸资阳气为可。

父母有瘕气者，其子必受之，犹如霉癩之系遗毒也。

霉毒入眼者，其始必头痛也。

诸出血后血气未复，犯风寒，则多成瘕。假令不成瘕，证候错杂，难遽愈。

一男子素有瘕气，偶感邪气，其热炽盛，谵语烦乱。医治之，热颇解，但心下冲逆，大便秘，元气虚惫，数日不能复。余诊之曰：瘕气耳，莫为意。因使绝药，治专饵食，而精气渐复，大便快通，全愈。此证虽元气惫，幸大便秘结，故知病可愈也。

喘哮下部肉脱者，属瘕气。凡瘕气逆上者，多下部肉脱。

其人脉数，腹气不和者，为中风兆，宜速灸。若缓漫经日，则因伤食，外感忽发中风也。

霉毒脉数咳嗽，与劳相似，但霉毒不肉脱，大便秘结，小便淋涩。如劳，虽小便浊，不淋涩，且肉脱或下利也。若霉毒下利者，在病末殆为凶候。(按霉毒咳嗽似虚劳者，霉疔新书栝蒌汤能治之。)诸病将死时，多见厥阴证，是必然理，不止伤寒也。

火动证病未发喘者，系下元失守，为难救。

喘哮甚者，与香效木、沉香亦可。仲景专用浓朴、杏子，此系无癖气者之治。在今世则多属癖气，故沉香、木香奏效也。余为制一方，茯苓、枳实、半夏、干姜、木香，共五味。

郁证与癆相似，但癆脉微细数，郁脉多沉，或虽见他脉，未曾至微细，是为辨也。

癆之极，有便蛔虫者，有下肠垢者，皆为濒死候。凡旧病羸劣吐下蛔者，皆濒死候。不止癆也，仲师厥阴所论为有旨。

劳发白疹者，多在胸膈而不在面部，此热气熏蒸，津液外泄也。其理与元气衰卫气失守绝汗者，同为恶候。伤寒发白者，邪气从而解也，故为善候。然宜与他证并看而决之。

蓄水者，阳气郁于中焦，上下不相和，故发烦渴，如五苓散证是也。

狂证以白虎汤治其里，以艾灸治其外者，此白虎消肠胃之郁热，艾灸散荣卫之郁滞，即寒热并施，内外兼攻之妙用也。(狂症者，灸心俞、患门、三里数万壮得效。《扁鹊心书》云：一人得风狂已五年，时止，百方不效。余为灌睡圣散三钱，先灸巨阙五十壮，醒时再服，又灸心俞五十壮，服镇心丹一料。余曰：病患已久，须大发一回方愈，后果大发，一日全好，是亦同揆。)霉毒壅塞经络者，患疰或痢之日，善驱除其邪气，则宿毒并去也。如他痼疾亦然。

妊娠与血块易混。然血块者顽固沉着，无发扬之势。妊娠者，凝结温然，有润泽之气。

又讯之于妇人夜阴快寝后，小腹勃然突起者，娠也。又ru头黑者娠也。(妇人经闭者：ru头多黑，故难一定。贺川氏《产论翼》有详说，宜并考。)后世以黄花、人参、为补涩邪气，误矣。今痈疽痘毒专用黄者，其毒自里达表也。人参亦同。(古方用黄主表达非补气，人参亦主滋阴，故柴胡泻心方中用之无嫌也。)本邦人性刚悍，不喜甘味，若强食之，则泥恋生气滞。西人性柔弱，喜甘味，故药方甘草分量每过于邦人。譬之于病患犹元气虚者，虽服人参多量不泥，在壮实者忽生闷也。昔者今大路一溪翁悟此旨，专主顺气，常用香苏散，而至甘草不用，匙以指头排散少许尔。(按香川修德顺气说。世以艮山先生为滥

筋，殊不知先生实本于一溪氏也。盖当时升平已久，浩然气皆馁，于是有顺气之说。盖万以根于气也。)求嗣法以温腰为主。故灸腰眼穴效，浴温泉亦效。

妇人有血块者，虽怀孕，临产时或难分娩。(拙轩曰：一种有横骨狭隘害分娩者，非手术则不得治，不可有知。)一妇人腹痛在脐上一寸许，按之惕然彻痛，脉数，乃断为内痈。饵以鸡蛋，服以黄、薏苡剂，后十日，大便果下脓血。

暑邪概自汗出，故难有表证，不枵发汗剂，与白虎汤类可。

狂证在妇人难治，霉毒在妇人易治。(妇人因瘀血发狂者易治，在男子发狂虽轻者不易治。)四苓散加汉苍术治雀目屡效。雀目多属疳，因治疳方中多用此品，亦能奏效。(拙轩曰：《眼科提要》云：四苓散加苍术，更加夏枯草一味，治晚盲极效。)戢菜能治结毒骨节痛，但其臭恶不易多服耳。

余每称心小胆大之语，以为医家吃紧。(先生之术，固创出前贤。然先根底医经经方，而复致力于思邈诸子。故其于大疾沉，自然游刃有余矣。)(拙轩曰：读此条，可谓名下无虚士也。)黄连性燥，虽浸水出之必干。黄芩性润，虽去水犹湿。故知芩连同治痢而各异性也，治呕亦然。

诸疮内攻为水气者，与赤小豆汤。热甚者，与大连翘汤效。

病患虚里动甚者，多遗精。(陈修园以龙胆泻肝汤治梦泄，曰以肝实而火盛也。沈芊绿曰：当先治其心火而及其余，宜黄连清心饮，亦与此说相发。)大病后表气薄弱者，偶感风冷则卒厥，此虽在夏月，属中寒也。(李挺曰：中寒冬夏同有之，旨矣哉。)(拙轩曰：与古人霍乱四时有之云者同。案俱皆理到此言，足互发明。)疟与痢同因而异其位：疟邪在表里间，而痢邪即着肠胃。故疟在外易治，痢在里难解也。(《医说》云：暑毒在脾，湿气连脚，不泄则痢，不痢则疟。而艮山能发其理。)噤口痢者，毒瓦斯剧甚，自肠中熏蒸胃口也，急与承气汤下之为得矣。若失下，腹濡口噤者，宜独参汤。

膈、噎、反胃、三者，同病也。但反胃者，胃中不和，饮食难化，或朝食暮吐。膈噎者，胃管萎弱无润，谷气不能下，或癖壅闭胃口，饮食为之妨害。故反胃反在壮年，而膈噎多属其人屡患喉痹者，多为膈噎，此因喉痹气管耗损，津液失润泽也。壮年者可治，在老人难治，何则？胃气衰弱，胃管硬强，譬之革囊，犹水渍火焦，则缩不能容物也。

膈噎与鼓胀同因属癖也。癖气横梁，腹皮为之膨胀者，鼓也。癖气潜匿，腹皮为之陷没者，膈也。二病俱系精气不振，腹里失润泽也。

凡长病面部肿气俄减者，阳气下陷也，不可忽诸。

其人气血凝结，腹里生郁热，水谷之气渐蚀以为羸瘦者，名曰劳瘵。此不必虚乏人，虽壮实者往往有之。

喘急有因奔豚者，此癖气上侵心肺也。(按三因息奔汤能治此证。)喘家其证虽剧。甚多无害于性命。若伤寒卒中诸急病，或缓病咳忽止但喘者，有不测之变，不可轻忽也。

积年苦头痛者，多属癖气，如偏头痛尤然。故癖气在右则右痛，在左则左痛也。

丹波一妇人患腰痛三年不愈，食干过腊鱼有效。(按恐是血沥腰症，花冈青洲治痿证，亦用干过腊鱼末，宜试。)痛风与脚气同因。而痛风其邪浅，脚气其邪深，故其愈亦有迟速之别也。

方今所行脚气，即《千金》、《外台》所谓风毒脚气也。宋元以来所谓脚气，即今所行疝气也。(后藤徽曰：吾邦往昔风毒脚气消熄无行，宝历以来，流行复煽，是以先子有此说。)中风偏枯，多因癖气壅塞经络，气不能外达。故癖气在右则右枯，在左则左枯也。

中风口眼斜者，因正邪分争之势而血气偏胜也。故斜在右则病则左，斜在左则病在右也，如半身痹痿者，亦同此理。

遗精多因肝胆气郁，又有因疝者，其证概腹中拘急，梦里精水激动而漏出也。其人虽每夜有之，反无脱阳之患，与构精者异。(拙轩曰：论病精细，近今世人多有此证，真无大碍。)小儿疳证，目盲，而其病愈者，与霉毒耳目鼻自毁，而毒解者同理。

妇人怀孕，则脏腑向上，故气多塞。紫苏能疏通其气，是以妊娠方中使用此品也。妊娠有水气者，紫苏大腹皮尤效。

按：当时传艮山先生术者，京师有香川修德、山胁尚德，浪华有市濂穆，伊芳势有山村重高，备前有赤泽贞干，家着户述，不乏其人。而后来私淑先生者，以筑前龟井鲁为最。曾着《病因备考》，补翼其说。又赋诗云：长沙太守元儒绅，述古兼医百世人。直指经方归易易，谁家私说言断断。枢机何用烦汗简，糟粕须知耻刘轮。卓乎艮山藤老子，才良仁术足相亲。

卷上

北山友松

友松胸宇洒落，以旷世之才，授闽医之传，善得法外之法。故治术别开生面，自有神识迢迈，触手生春之妙矣。

友松尝善象胥学，又从禅僧化林学仲景奥旨，就戴曼公得《内经》、本草精蕴，既而谓皇朝医风亦不可不研，乃师小仓医员原长庵(冈本玄治高弟)，遂大成其业。

虚劳有直肠疼痛大便难，或发痔漏者，此皆系肺大肠损伤，为难治。(常屡诊虚劳者，发此证颇多，而百无一治。古云肺与大肠为表里，理或然。)敛血品以牡丹皮、荆芥、蒲黄各炒黑为奇。(本邦妇人套药皆炒黑为用，即此意。)阪本人年五十所，郁郁不对人，饮食减少，颇如劳瘵。先与补中益气汤，后以九味清脾加葳蕤得愈。凡开达肝脾之郁塞，无若清脾汤。若逢肝脾郁塞，以认此汤主治为要。

一妇人三年不语，一月内或一二言耳。乃以为脱营类，与人参养荣汤，易裘葛而愈。

盗汗不止者，九味清脾汤加地骨、鳖甲、椒目奇效，当归六黄，加地骨、防风、桂枝、黑姜、椒目亦效。椒目能敛汗，古人尝论之，今忘其出典。(香川修德药选论椒目效最详，悉宜参考。)一男子得病，其证类膈噎。友松诊之，以为心脾肾气不足，胸膈无润泽，故食饮不能下。与八味丸料，加菱仁、贝母、陈皮、缩砂，兼用金匱大半夏汤。(参五分至一钱，时用参附汤。)霉毒头痛久不愈者，柘榴皮酒煎服忽差。盖此证医误以风药发之，故柘榴皮涩之则愈也。先醒斋头风神方亦效。(土茯苓四两，金银花三钱，蔓荆子一钱，玄参八分，防风一钱，天麻一钱，辛荑花五分，黑豆四十九粒，灯心草二十根，芽茶五钱，河水井水各一钟半，煎一钟服。)某生胸下上脘边突出，气急烦闷，与异效散加椒目愈。又目疮，(俗称女波津古一名女保者。)用升麻葛根汤加椒目效。

友松以养荣汤或左归丸料，治虚羸，专视十指爪甲血潮之多少为消息。盖辨血色之好恶在爪甲，不可不知。(老医传云：诊脉毕，宜以指按病者爪。按之白放之红者吉，虽久病可治。

放之红不复者，虽顿病甚凶。香川修德行医言，亦载辨爪法宜考。)呕吐膈噎食不下者，半夏、浓朴汤，加海浮石、枯矾效。

乳肿属气滞。乳汁不通者，四物，加王不留行、穿山甲效。

霉毒为残害者，主小柴胡汤，随证加减多验。(按医纲小柴胡汤加草龙胆、黄连、胡黄连，治旧下疳疮。忽头痛发热自汗，撮要小柴胡去大枣、生姜，加山梔、龙胆草、当归、芍药。

治肝经热毒下注，便毒肿痛，一切疮疡，或风毒恶核瘰，此类颇多，宜考。和田东郭曰：凡霉毒有热者，先不解其热则不愈，此即用小柴胡汤之旨。)土佐翁(谓长泽道寿。)隐栖西山，一日诊京师商人痈疽曰：宜日服人参五钱。后五日诊曰：未见参效，恐不治。病家告实曰：服参一日不过二钱五分。翁曰：贱命重财，无益矣。苟欲生则服参，宜今日五钱，明日六钱，又明日七钱，渐次相进。商如其言，七日病果愈。友松曰：用参将息适宜，可谓得补托之真诀矣。

土佐翁着《医方口诀集》，三日而成。有马氏凉及手写《证治准绳》全帙，以谥记其卓识，笃志可并称。

治头痛，薄荷、石菖、葛粉、川芎、白芷，五味细研，蜜炼服效。平常患头风者尤妙。

杂着化痰丸如白刀豆，以治痰妙。风痰结心包健忘者，无不效。一僧疫后患此证，服之速愈。

过服石膏下血者，补中益气汤加肉桂、干姜效。

妇人下部水肿，或小便不利者，枯矾细研，以涂涌泉穴及指头，则尿利肿消。

痘疮以日数证候变者，其理与伤寒传经同属疫气故也。宜知元气旺衰，邪势剧易为要。若徒执黄、当归、人参终始疗之者，不足与论也。(按隋唐医书皆以痘属疫，迨宋元胎毒说起，其理遂晦，先生特阐之，可谓卓见矣)。

疫证舌上白胎者，热入腑也。赤烂干燥者，热入脏也。张氏舌鉴论之为确。

张景岳制人参胡椒汤，为有深旨。凡极虚者，附子反走散元气。故与附子则脉却伏结，不可无此汤之设也。

一妇人喜唾，数日不止。医以为虫积或虚冷，治之无效。余以为郁，与正气天香汤，速愈。(疫后喜唾不了了者，一老医与大柴胡汤速效，是亦属郁者。)《准绳》伤寒门伤寒类伤寒辨，学人宜熟读谥记，使门人各书写一通。

妇化医某始疗病，每服药重七八钱，甘草分两尤多而无效，人皆以为庸工。某曰：吾过矣，国人比之于唐山腹力颇弱，故不能中肯綮。便减其分量，杀甘味以为之，无不百中也。

治病必求其本，乃往圣之模范。随证而施药，是后学之应用。及治四时伤寒，各随其类，岂可局于区区论说哉!(医家宜当之羹墙。)明太祖论徐达曰：更涉世故则智明

，久历患难则虑周，吾业最为然。(以救己之心，推以救人，所谓现身说法。诚千古不磨之论。)夏布政字正夫，未尝以淹屈降志，尝曰：君子有三惜，此生不学一可惜，此日虚过二可惜，此身一败三可惜。余续之曰：有善不作四可惜，有过不改五可惜，老来怨天更可惜。

《骨空论》曰：厉风者，素刺其肿上已，刺以锐针，针共按处出其恶气，肿然乃止。常食方食，无食他食，按常食以下八字，为治难病之妙诀，不止厉风。故余一生以为治病药食之准则矣。又按张氏注云：食得其法，谓之方食；无食他食，忌动风发毒等物也。此说未是，方食即谓方宜惯食之物，他食即谓所不常食之物。言食膏粱之人，试以淡泊则恶；茹藜藿之人，试以美食则伤食，不唯却其病，反生他病。

东垣《辨惑论》当为一卷，今别有二卷者，恐系后人之手，何则？举补中益气以至暑伤胃气，即说正月以下三四月治法。肺以下至脾胃虚，即说五六月治法，下之至内伤辨，皆属九月以至十二月之治法。一意到底，不可为二卷者昭然。

李氏辨内外疑似证最精矣。且如气少气盛辨，益于后学不为鲜。然至内外相兼者，李氏说未为尽，宜涉猎古人书以补其阙。

下元虚损，精气枯槁，人外感风寒，颇似温疫者，或宜先补虚，或宜先发邪，或宜补泻相兼。此际医最可苦心处，固非笔墨之所尽焉。

《医药纲目》别为一家，与他书体裁自异。钱氏论小儿亦自一派，据之不为可，不据亦不为可。(拙轩曰：有明一代医书之多，汗牛不啻。所谓类比者居多，戴复庵、吴有性、陈实功之外，仅仅数家耳。《医学纲目》亦庸中之佼佼者，此言有味。钱仲阳之于哑科，颇为大家，然见为一派，真是有识之言。)疗伤寒知去路来路为要，或表入里，或阳转阴，或前在某位，后进某位，或始终一位。

审之以处方，思过半矣。喻昌曾辨之，可就见焉。

余常主实学示子弟曰：经络脉说不可不知，而深拘之则反失于实用，学人固不可无取舍之见。

余不喜讲说，唯正月初八祭神农氏，使门人讲《上古天真论》耳。(其说曰：听讲义鲜益其效，不若熟讲百遍，盖在心悟。此可以为世医信耳不信目之戒。)余晚年读本草日夜不释手，故其用药虽一味无赘品。

余疗南源悦山高泉诸僧，皆用大剂何者？西土人比之本邦颇浓肠强胃，非轻品所敌。风土人物之异，不可不知。(西土医诊病直记其药按以与病者，病者购之于药铺以服之，故其品剂量适，正与邦医轻剂射利者迥异。)甘麦大枣汤，治产后似邪祟者奇

效。(按：所谓如有神灵者也。)伤寒壮热烦渴，小便赤，不大便七八日，舌燥目赤，时闭乍开，仅啜粥汁耳。一医与清心温胆汤去香附，加辰砂、淡竹叶、而谵语益剧，脉伏不应。因与白虎汤合黄连解毒汤，诸证自若。乃煎人参三钱，黑姜一钱，兼服之脱然愈。(按：此与吴有性承气加人参合辙。)建中汤入口则痛乍止者，甘以缓急也。甘草粉蜜汤治心痛，其旨颇同。膈噎服蜂蜜，一旦纳食亦同意。大半夏汤之于蜜，不过此意矣。

张仲景一书，炳如日星，亘千古不可磨灭，熟读者知其意。(当时医多读《素》、《难》不读《伤寒论》，故发此言，以示为万世理道之神书，救人之秘典也。)《内经》终始一言以蔽之曰：亢则害，承乃制。(经云：知其要者，一言而终。不知其要者，流散无穷。可谓真知其要者。)东垣本于《内经》阳气清静则四维收之意，制补中益气汤，深得经旨矣。在本邦土佐道寿善研究其意，故治脾胃手段最长矣。

罗氏曰：七分内伤，三分外伤者不治，是善得李氏之意者。

治疗之法，先泻后补为易，先补后泻为难。

丹溪斥《局方》者系救时弊，门人戴氏专用《局方》，其意可知矣。

古林见宜疗纪州熊野山中农夫水肿，服药良久无效。因加青芋于方中，又以之为朝夕餐而病愈。盖其人生于山中，以此物为常食。而偶出于浪华请药于众医，禁忌亦随严。故脾胃失常度，药力不能达，是以施方宜之术也。

咽喉痛颊肿及呕哕者，小柴胡汤连翘各等分服之效。

水气不论新久，欲持脉不能遽举手，或欲按足跗不能伸脚而微喘者，死证也。肿气一旦减乍复者，亦不治。

淋疾与五苓、平胃、泻肝诸汤。茎中涩痛甚者，补中益气汤加蒲黄(大)、五灵脂、金银花效。(按：内注下疳远年不愈者，与此汤亦效。)常海初学用零纸书古人医案，各处其方，以得其当为上等。

凡方证虽相对，分量有不过及，则不能奏效。故葛可久损伤病论大黄多少至密矣。况如中气卒厥之于人参，阴虚之于龟板，其多少不可不最密矣。

友松治肿胀用补气养血汤，十愈七八，盖此方不用利水品，而肿胀难治者，间奏大效。

其意在专治胀也。

一医生读喻氏《寓意草》，友松闻之曰：喻氏之书不无益，然以之为治疗之模范，恐为下工。

呕逆诸治无效者，及诸呕吐不能服药者，与旋复代赭石汤效。盖此方人参、代赭相伍为妙用也。如白通加猪胆汁汤，其妙亦在附子、猪胆相伍也。

闽人化林老汉传治眼暗失明，用鸢首霜，此理高上可玩味。

摄津池田有一奇病，其证两脚酸疼，渐肌肉削小难屈伸，遂成痿，俗名曰池田病。此病他人间患之，而皆受之于池田云，友松与独参汤愈。

八味丸为转胞之套剂，而服法非逐次增分量则无效。此即益水源之意，宜三钱至八钱为妙。

小剂药量时不无效，《医学正传》有其说，汪认庵亦论之。

积气气郁，或夜中发热等病。有发止者，详其由有患疟者，虽数年后兼用阴疟丸。则奇中焉。

闽人传治贫窶消渴，水中腐木一味为散服。又治头风，鸢头霜烧酒服。友松治一武弁两眼旋动，与鸢头灰。盖扩充此意云。

凡用滋补滋阴药，方中无陈皮、半夏、木香、砂仁等，则不能达药气，此理尤不可阙。

(按古人黄建中汤加半夏者，即此意。)方者法也，如毁旧屋而建新屋，故使方而不使于方为要。假令如以中风方治咳嗽是使方也，若以风药治风，以咳药治咳，是不使于方也，况索病根而治之，诸证不治而自治，乃上乘法。

下部肿与防己茯苓汤，上部肿与茯苓补心汤，并奏效。妇人肿气多属血分，防己能入血分，故多效。若属气分者，茯苓、泽泻为主。若男妇阴虚为肿者，六味地黄丸加附子、防己、苍术效。又肿病元气实者，大承气汤为丸用之效。

《证治要诀》为必读之书也，如藿香正气散加木香以为一方之类，其意尤可称。江州坚田村北村道卜者，年可六十，患中风，京医几岛氏疗之无效，因延余。余诊曰：欲速愈，则后三年必再发，以至不治，若不欲速愈，则十五六年当延其寿，二者请选之。病者曰：荏苒弥年，何堪其久，愿速愈以谢朋友。乃作异功散，加乌药、白芷、青皮与之，服五十贴全愈。后三年果如其言。门人矢岛安节问缓治之方。曰：十全大补汤为得焉。

友松在北村氏家隐几而坐，一女子将请诊。请诊，望见叱之曰：汝妒心溢面，可深恶。

女子赧然谢服。因语曰：汝神彩甚病矣，苟有悔心，余善疗之，即与药而愈。盖此女嫉妒多年，夜则穿户窥隙，颇如狂人。而友松一见洞视，人服其技云。

阪阳老医问起死回生之方。答曰：方无灵，唯求其本耳不言其他。

凡病虚实难辨，补泻难决者，能察其脉证，审脉可据，与证可执。而从其确者，则治法庶无愆矣。

江州北村左太夫虚羸不食，一日气息奄奄将绝。急延林市之进诊曰：血脉衰弱不绝如缕，庶几万一耳，乃作剂。仅用人参一分，龙眼肉一个，众皆危之。翌朝来诊曰：证候如前，而毛窍稍塞，肌肤少和，是脾气旺肺之机，乃可望生。因倍人参、龙眼肉与之，果愈。友松闻之叹赏曰：极虚者投大剂纯补，譬如灯火将灭急灌油，不减何俟。林氏可谓得补法之蕴矣。

浪华菱屋素闲，年六十余，形羸不食。其初得之于伤食，诸医治以香砂六君子汤、七味白术散，无效。友松与异效散加汉当归，三二贴而愈。又金田铺某女不欲谷食，唯食他物，诸治无效。乃与四物汤，加人参、白术、橘皮而愈。门人问其故，曰：脾胃血液虚则枯燥不能食。

汉归味甘，能益脾中之血，是以为进食之剂也。经曰：手得血而能摄，足得血而能行，肝得血而能视，据之则肝云云下当补胃得血而能食一句。

大七气汤治妇人久咳不止，其意可味。

瘫痪经年者，一旦忽然手足动，目睛爽，即急变候。

久病及大虚人，尺肉脱者，及指头不能急屈者，多不治。(片仓鹤陵曰：凡病患肌肉柴瘠者，手腕后肉脱而形匾，医握其中央指头将相合者，不问何病为死候也。虽饮食如故，此游魂之假息耳。劳瘵之病，累月后必见此候。唯伤寒痢疾脚气后有此候者，往往愈，盖本于此。

)《脉要》旨在颐生微论，不可他求，唯本草揭脉处亦可并读。

痢疾呕哕诸药不入口者，黄连一味小剂服之，药食共得下后见蛔证，因前方合大七气汤与之，此法本于薛氏治太宜人案。

友松所着《医方口诀集》，纂言方考等首书。读之深知学术富瞻，游刃有余。独至北山医案，徒摹仿古人，局守法度，终乏高逸之气。学人读之可，不读亦可矣。

卷上

和田东郭

复古之医术以吉益东洞为最，东郭出其门下，独不奉其衣钵，别成一大家。盖譬之兵家，东洞医如韩信行军，背水绝粮，置之死地而后生。东郭医如李靖用兵，度越纵舍，卒与法会。

各有其长，不易优劣。学人于此处着眼，庶几得二家之真矣。(拙轩曰：古人往往以兵家之事拟医术，先生以韩信李靖评二氏更妙。)病瘫痪肩骨开脱如容五指者不治。又握掌不开者不治，开而不握者治。

《证治准绳》论婴儿尤精，足以见王宇泰之苦心。转胞六味丸治验亦可玩味。

病转胞脐下有块，其形圆者治。若扁如柿核者不治。此证以八味丸为套法，而四逆散加附子，抑肝散加芍药亦奏效，不可不审。

水气不虚不实，其肿光艳者，鲤鱼汤为得。

水气入胸膈，及肩背拘急如束缚者，为犀角的证。

一角能治水气上冲，故用之脚气冲心颇效。

打扑有似瘀血冲心而否者，曾睹山陬一妇人大损伤，精神昏愤。腹中如杯盆者，迫于心下颇闷乱，脉息仅不绝耳。余作走马汤与之，服已须臾，烦躁，吐泻清水数升，霍然而愈。故知不可慨为瘀血而治也。

油风多用大柴胡汤而效。是宜治其腹，徒不可泥其证。(华冈青洲治此证，以大柴胡加石膏汤，曰油风多属肝火，亦同见。)每称东洞曰：先生治足委弱不能步行者，与桂枝加术附汤，兼服紫圆速愈，可谓妙矣。

(此上焦得通，津液得下之旨。东郭夙入其室。)(拙轩曰：青洲翁疗梅疮结毒，顽结难愈者，用桂枝加术乌汤，兼用消毒丸，应手而痊。盖从此处脱胎来。)一妇人年三十有五，背脊佝偻，身不能动摇，足屈而不伸，脉沉紧，其形如十岁许儿，即与理气汤，兼服紫圆，六月后与慈菇汤，脚伸病方愈。

桃花汤治痢病便脓血极效。盖初起与之无益，其期在热气稍解，脓血不止。论曰：二三日或四五日其旨深矣。

余常用桃花汤为散，白汤送下得效。若少阴病形悉具，特便脓血者，以真武汤，服桃花散亦可。

世所称中风多因痰为偏害，宜诊腹以处方，故大柴胡汤加甘草，抑肝散加芍药等，能治此证。其他如手足痺痿痺，亦世医徒拘其证，不察其因，宜矣不得其效也。

一老人痰喘气急有痰，细柳安以为劳役，与补中益气汤，痰喘益剧。余诊曰：此人性豪强，壮年起家，故肝郁生症，加之水饮聚结以为喘急也。乃与宽中汤加吴茱萸，病安后感寒为下利，因与真武汤利止，以四逆散加薯蓣、生全愈。

一男子犯寒夜步，因感冒短气，手足微冷。医以为中寒，与四逆汤，服后短气益甚，咳嗽面赤。因与越婢加术苓汤顿愈。

病者目赤眼睛不转如鱼目者，为难治之候。

病患不论缓急，将诊之。宜隔床望见其形气，形气缩小，神彩枯瘁者，死候，不必持脉而知之。

脱证误与攻击药，则爪甲忽失光泽，不可不知。

神阙脉亦为治诸病要诀。按之沉小不移者，形体虽虚，为实候，宜攻之。若浮芤无力者，为虚候，如水分之动亦同之。

伤寒舌圆浓者，又薄小者，皆为恶候。又始终白胎不变者，亦为难治候。又浓者赤者，皆为虚也。(卢不远曰：伤寒可以神舌识病。则风暑燥湿，恐亦有定法。此言诚为隅反矣。)脐下悸，按之与呼吸相应者，病患虽危笃，其死有间。脚气、劳瘵、湿毒三病，当脐上五六分任脉外各一寸许，不拘左右必有动气。脚气则弦急，劳瘵则虚数，毒则无定形。

凡大病眼中爽者恶候，不了了者反有生意。劳瘵及杂病眼神与病相应者为佳。

诊大病鼻梁亦为要诀。医书徒论明堂而不及此，为阙典。

腹胀攻下无效者，有漫游散气。则顿愈者，此因心下素有积为胀满也。(按《灵枢》云：夫胀者，皆在于脏腑之外，排脏腑而郭胸胁胀皮肤，故命曰胀。东郭所论，盖斥此等之证而言也。)石膏非大剂则无效，故白虎汤、竹叶石膏汤。其他石膏诸方，

其量过于平剂。世医不知此意，为小剂用之，譬如一杯水救一车薪火，宜乎无效也。(拙轩曰：此言甚好，伤寒诸方之石膏，则剂可大，而服数不可多焉。至杂病，则非大剂决不能奏效，放胆用之而益可，况今医人恐石膏殆如蛇蝎噫。)感风寒咽喉肿塞，药汁难通者，作驱风解毒汤加桔梗、石膏冷服，极效。(拙轩曰：此证小柴胡加桔梗、石膏，亦奇中，青洲翁曾用之。)伤寒大热烦渴谵语，欲饮水数升者，固为白虎汤、承气汤的证。而又有假热者，有水邪者，故真武汤或犀角、生类。有时为市医者，宜审脉证谛腹诊以决真假矣。

伤寒面合赤色者，升阳散火汤、犀角汤(《医学纲目》)间效。若服之二三日不愈者，多为戴阳难治。

治疗有先后之序，紊之则无效。一病患足心至胯间烦热，日夜数十发，殆如有火往来。医以为脚气，治之不差。余诊之，脐右以至少腹磊块应手，此属燥屎，因问其大便曰不通。乃作调胃承气汤与之，燥屎悉出而后治其脚气，诸证全愈。是其明征。

疝阴囊肿大与治疝诸方不愈者，与半夏浓朴汤加犀角速效。又经闭与逐瘀诸剂不治者，与安中散、抑肝散等得效。是皆欲得南风，必发北牖之理。医不可不知此活手段。

小儿慢惊风及中暑者，其口为如笑者必死。

因毒瓦斯而声哑者，加喘气则多死。

吴氏所论疫京师十年前大行，其后绝无。盖疫者年年异其证，而发于柴胡者多。则募原说不为无理。(仙台工藤周庵着救瘟袖历论，因时运异证。亦可参考。)霉毒家口中烂、耳鸣、咽喉腐蚀、头痛、肩背痛、声哑、吐沫、齿断强直，八证者，皆系轻粉毒，宜详之。

天庭色衰者为虚，色盛者为吉，色痿有皱纹者为难治，日月额凹陷者死，失色者为难治，无生气或羸脱者死，耳痿失色者死，发际有白点者死，面冷或鼻冷或少商穴冷者死，额上冷者死，此皆望色决死生之要诀也。(按：《医学正传》小儿门汤氏说云：山根若见脉横者，知两度惊。相书鼻为山根，山根有疾，尤非佳兆矣。然东晋谢安、北宋刘贡父俱有是疾，一则德望盖世，一则博识该览。居一代诸贤之右，亦不可拘物理小识云：小儿乳哺时母有孕，辄眉心黑泄泻，据之则眉间亦可精察。)胁下引背脊痛者，多属畜血，不可概为悬饮。

世所称脓淋者非淋，即《外科正宗》蚀疳也，宜解毒剂。

急喉痹秘寒不能饮下者，与苦酒汤效，或平素患咽肿者亦效。一男患咽痛，后元气衰乏，下利咽肿而燥，难言语者，与苦酒汤，初痛楚不能咽，后快通愈。

病患绝脉者，暴出为恶候，微续为佳兆，不止脉如厥逆亦然。

治病求本为要。譬如鼻痛、耳痛、耳聋，徒为耳鼻之治，此即舍本执末也。为医者宜认其所以然而治之。

用方以活变为主，某方治脱肛，某药主下血，概用之者，不知活变也。一方以应万病，万病以归一方，是谓活变也。

心胸痞塞，用芍药、甘草类不应者，半夏浓朴汤加芎，轻其剂量而服之则效。(拙轩曰：如此条所言东郭翁极得意手段，玩味有余，下条亦然。)泄利与附子剂不止者，钱氏白术散奏效。此理可玩。

一妇人羸瘦盗汗，下利十余行，腹中拘急如摸罗网，不欲饮食时喘者，与真武汤愈。

伤寒与下剂，以其脉沉实沉紧为的也。(此语非大有见识，大明脉理者不能道，诚与仲师用承气之旨符合。)病患有心下痞硬，腹中拘急而遗精或漏精者，概为下元虚治之，则痞硬益甚。先治其痞，则遗精亦随愈。

病咳血心下有水，左肋及胁下拘急动悸者，与柴胡姜桂汤加吴茱萸、茯苓愈。此治腹而血自治也。(拙轩曰：翁之用四逆散、柴胡姜桂汤、八味丸等，纵横颠倒，变化无方，实极得心应手之妙，他人不可及也。然精思求之，岂不得其仿佛乎。)诸疮内攻，及脚气上冲，与木瓜、吴茱萸、犀角等无效者，四物加黄柏、山梔子，或四物加浮萍能治之。盖不制水湿而治血虚，最是上乘法。

生地黄能治心下痞硬，干地黄亦然，但其效不如生耳。

京师一时咳嗽大行，有人患之，诸药无验。荻野台州以为下元虚，与八味丸不应。诊之左肋拘急，因与四逆散加吴茱萸、牡蛎速愈。

一妇人数日自汗不食，脚挛急，脐下有块而痛，其状颇似蓐劳，众医治之不愈。余以块为主证，与安中散，块渐消，汗随止，全愈。

久腹痛者，徒禁浓粱而不减饮食，则虽方证相对，更无效。

腹痛发呕吐者，不详其因而治之，则误人不浅鲜，因者何？曰积聚，曰停食，曰蛔

虫，曰水饮，曰瘀血，曰肠痛是也。积聚心下痞硬，按之则反胀。停食心下濡，按之如空，蛔虫按之指下有气筑筑然。瘀血多在脐旁及少腹，按其痛处块应手。水饮其痛游走不定，按之则鸣动。

肠痛多右腹，按之左右异状。且手足痛处则必觉润泽，右足挛急，小便淋沥。余多年潜心辨此六者，无有差忒。

风眼痛剧者，与紫圆六七分大下之即效。(拙轩曰：专门眼科曾有此快活手段耶。)霉毒热甚者，以清解为主。若解发不彻，则多为沉痾废疾。此法医书未说及，为可深惜矣。

偏枯证有治不治之辨，病者握手者决不治。试使握手仰卧，则其手必开，复起之则如故，是为恶候。

禁口痢者，胃口至胃中多畜水饮，故水分动气甚。附子理中汤加粳米，或加薯蓣、生效，又将生鸡肝入酱煮熟取汁服之。

掘河丸太街一富商女年十八，患麻疹，其状细小，欲发不能发，隐隐于皮肉，大热如火，呕逆，水药不能纳口。余以为热毒内攻所致，乃与调胃承气汤，病阻不能服。因延田中信藏诊之曰：余有浴法试之，家人疑议。余曰：药不能下，施之而可。信藏乃以清酒和热汤盛之于盘内，使病者沐浴其中，须臾出之，温覆取汗，则呕吐忽止，疹悉发。(拙轩曰：魏氏博爱心鉴水杨汤浴痘儿之法，与此条同巧异曲。)治痘法以辨胃强弱为要，虽有利、烦渴、寒战、切牙等证，胃气强者可治。补泻之分，全在此一途。

老人顽癣，多因血液干燥，湿热熏肌表。故温清饮为的治，或加浮萍佳。

脚气动气甚者，四物汤或效，盖以水分动为标准也。

嘔逆属胸中者，主橘皮、竹茹、丁香。其属腹中者，主附子粳米汤，合甘草干姜汤。若有水饮中气虚者，主香砂六君子加芍药也。

产前后口舌赤烂痛者，实者以麦门加石膏汤，三黄加石膏汤为主。在虚实间者，以加味逍遥散为主。极虚者，以附子汤加当归为主。若赤烂生白点者，为恶候。加下利者，为不治。

诸病其脉时时变易者，属痢也。

余曾谓芍药缓肝，当归润肝，川芎疏肝，生地黄泻肝。其能各异，而要之不能出肝

分。

卒厥人趺阳脉应手者，为恶候，何者？胃气脱则趺阳反鼓动。宜审其神气有无，吐与利证异而因同，医当晓其理。

诸病凝结心下者，多属肝气。疫证亦多挟肝气，宜察焉。

赤游丹毒不早下之，则内攻为走马牙疳，宜凉膈散加犀角。

霉毒上攻，头上肿起为凸凹者，属火证。宜温清饮，霉毒动生火，不可徒为湿而治焉。

久病患左右偏卧者，一朝忽得自由卧，则死期在近。

池田瑞仙(锦桥)诊痘甚粗，如不用意者，或人问之。曰：诊察过密，则反失真。其妙存于目击之间，譬如睹刑人之就死地，虽刚强者其气馁，憔悴之状，在过眼之间，若熟视久之，则其形气与常人无异矣。余治妙法大王臣菅谷中务卿男，啖柿果伤胃，发大吐泻，四肢厥冷过肘膝，换数百方治之无效，束手俟死。余望之形容自有生气，因与理中安蛔汤，忽苏息矣。

是前医则熟视刑人也，余则一见于道途也，可谓瑞仙真得实诣者矣。

患囊者，足痿就蓐，则多不治。

结毒入眼瞳人陷缺者，为用汞剂之的，非他药之所治也。消息与汞剂，则瞳人圆满复故。若不圆满反紧小，神水流散者，不治。

因结毒成聋者，成青盲者，成声哑者，皆不治。但聋耳有所少闻者，远房服药，则愈。

服轻粉口中腐烂者，石榴皮、松脂等分煎服效。

凡与粉剂者，先与泻火药，而后与之为佳。此与疔打扑者先行拆水，而后服，酒奏全效，同一理。

会阴打扑小便不通，但少尿血者，与桃核承气汤。若不瘥者，与大黄附子汤一帖，用附子二钱为佳，服之小便快利血止为度。又因证可与八味丸，是真藤元志试效方云。(拙轩曰：会阴打扑其证剧，并尿血涓滴不通苦闷者，内用甘遂、大戟峻剂，外施导水管，不然无救法。

此条所言，盖属缓证。)癖逼塞胸膈者，脉异左右，癖之所在，其脉必涩，癖之所无，其脉必数也。又有其人常脉迟，因癖而为动数者。

癖人横卧有下癖而眠者，有上癖而眠者。审之其下癖者，必因胸中冲逆甚也。

舌色纯红而柔软，其形失常干燥者，为参附所宜与之。舌色不变者，恶候也。若无汗谵语烦乱，舌上焦黑无芒刺干裂成皱者，亦为附子所宜。盖此证其脉虽浮洪或弦紧，必无根抵。与附子，病势缓则脉必见虚候也。盖舌纯红者属阴虚，而焦黑者属虚火也。又有证具阳候而舌上反无胎润泽者，为恶候。若此证必胸有所闭塞者，与药开达心胸，则舌上生胎也，为佳兆。又虽与药制之热愈炽，胎不更生者，为不治之证。又服药后，舌胎一去其色不和者，有宜石膏者，有宜附子者，有宜地黄者，当审别焉。要之舌与脉者，阴阳虚实之所判，不可不细精，故吾门加四诊以腹舌而论定病因虚实也。世医不知之执腹诊，舍脉舌，可谓疏漏矣。(拙轩曰：宽政年间水户土田恕庵着舌图说一卷，据张路玉舌鉴等。附以己所见，颇为详明，可谓得东郭翁之心者。)舌上不论黄白带光滑而干燥者，附子所宜也。其红色者，益为附子的证矣。

病患舌上白胎，其下含紫黑色如牛舌者，为恶候。此舌候兼面戴阳，则更为危矣。

按舌候大概诸疫无异，故疫痘皆同诊。但至结毒则具一种舌色，不可不辨。(白胎中带黯色者，及舌下赤色中成皱纹者，又紫色如牛舌者，皆属结毒也。)崎德见茂四郎者，(丝割符年寄。)患鼻渊三年，诸医以为肺虚，百治无寸效。诊之两鼻流浊涕如檐滴，脉弦紧，腹拘急。予曰：此系肝火熏灼肺部，上下气隔塞之所为。世医不知之，漫认为肺病，或误为风邪侵肺，徒用辛荑、白芷之类。宜乎不得其治也。乃与四逆散加吴茱萸、牡蛎服之，半月许，病洒然愈。盖此等病宜详其脉腹，而处方不必四逆散也。

凡病患胸膈不开，则必下不宽，故欲制心下者，先治其胸膈，是医家一大紧要。窃比之于净土门一枚誓词。

一妇产后经二旬，卒呕吐数日不止，左胁下冲逆痛剧，与吴茱萸汤(参用洋参)忽安。

产后腰膝痿弱者，多系癖所为。盖其初妊时患水肿或脚气，至产后气急者，与对证药。前证愈后，当详腹延医癖，此证最要艾灸。若施汤流及艾灸癖为之压不瘥者，与桂枝加术附汤、麻黄附子细辛汤，而二三日或四五日之间，以紫圆下之则愈。此即先师东洞翁独得之妙，而余则因其证与四逆散、理气汤、十全大补汤等，时时以紫圆下之，每得效。

紫圆以荡涤胸膈为主，故发狂上炎，甚者及产后痿弱，心膈气不能下降者，皆用之效。

昔东洞先生曾以此方治龟胸龟背，即此旨矣。

目疾属内障者，艾灸最效，而专门者忌之为可笑。其他如黄风雀目、肝虚雀目，不知其辨动误治。盖黄风者，白睛中生细皱发黄色，用滋阴明目汤、八味丸，单杨抱术等效。肝虚者，乌睛白睛如常，但觉昏暗，故为难治。

松原一闲齐者，吉益东洞山胁东洋师友也，本为若狭候臣尝治龟胸龟背。及痿沉痼者，用起废丸，其方大黄、生漆、二味研末为丸，未干时服一钱或二钱。服后大热发赤疹为知，而因证与他药则全愈。

一闲齐门人桥诰顺治。治一妇人，头发发火，每梳之觉火气至即见光，与三黄加石膏汤痊。

予亲见一妇归家，衣里有爆响，投之于暗处皆见火，此皆肝火之所为，不足怪矣。(拙轩曰：明郎瑛七种类稿卷二十六有衣火一条，与此同日之谈。又见张芳洲杂言：按人发猫皮暗中以手拂之，常见灯光，且闻爆响。西洋人以为电气发出之验，不必肝火之所为也。《医剩》云：先考蓝溪公所识一贵妇，每暗中更衣，火星爆出，同妇女栉发，于暗中及猫儿背毛逆摩出火之类，盖体气盛者，偶有击而发光者，非真火也。)十枣汤证有下痢者，因上迫势甚而热下陷为利也。故与脱利其趣迥异，如柴胡泻心下痢亦然。

痘疹下利与伤寒合病下利同。但及十余日者，与少阴下利同辙，正为恶候。

天津小野又三郎者，患天行发呃逆，五六日微利，其脉变幼无测，众医以为脱候皆辞去。予诊视半日许，谓旁人曰：此脉非恶候，即肝火亢盛之所为。因四逆散加地黄、古金汁服之，脉顿定，诸证随痊。

便毒无脓溃，势将消散者，内托剂更无效。与三物楸叶汤，若不起发者，加附子，服之无效者。概因痼痂为之妨害，与四逆散加附子奇效。若终始无脓溃势者，与芎黄散加荞麦可下之。

小儿胎毒系先天，而世医不知之，或言分娩时误饮瘀血为可笑。凡诊其毒，先以指头按肋下，心有凝结。而因其缓急，可察毒之轻重。又面色灰白，或暗黑，或过光泽，皆属胎毒也。

若受父母霉毒者，最为难治。

其人平生一手脉不应者，偶者之固无害。若四十以后，一手脉暴绝者，为恶候。此证多房者多有之宜详。

大腹痛服建中汤无效者，认水分动气与莎汤则愈。又左胁下逆抢痛甚，与诸药无效者，有水分动则与地黄剂效。

水分动有三：道属肝肾虚火者，为地黄薯蓣牡丹皮之所宜；其动在表泛应者，为茯苓之所主；其动无根蒂，脐中齐鼓激者，所谓肾间动属不治也。

京师书肆梅村氏曰：江户千钟房有治积气血奇方，名顺气散，即四物汤、香附子等分研末者。予以为此方有理，因制莎汤屡验。

一男子年二十四，得病五年，右膝肿起如别束筋肉，不能行步，其状稍类鹤膝风，而其诊腹右脐下拘急最甚，按之右足挛痛甚，其性急不能堪物。予以为肝癖固结之所为，即与大黄、附子加甘草汤，数日癖块发动，病稍缓，因与四逆散，加良姜、牡蛎、小连翘全愈。此证世医不知，徒为脚疾，用葳灵仙、杜仲、牛膝宜矣，不得其治也。当详其腹候而治之，此即余积年粉骨碎身之所得，殆为医家之新手段矣。(拙轩曰：此治验翁极得意手段，读者宜究心焉。)发闲人事不省，药汁不下者，宜艾灸。最要大壮。不彻者，昼夜灸至七日为度。伤寒发痢者，亦宜此法，大灸至闲瘥，则邪亦随解。此理医经所不闻，故世医恐热忌灸，可笑矣。(窦材曰：医之治病用灸，如煮菜需薪。今人不能治大病，良由不知针艾故也。又曰：世俗用灸，不过三五十壮，殊不知去小疾则愈，驻命根则难。故铜人针灸图经云：凡大病宜灸脐下五百壮，补接真气，即此法也。彼此同见，可谓海外子云矣。)平素有疝瘕者，得大病其块忽移处者，甚为恶候。

患霉毒不外达，蕴结脏腑，兼见疝瘕者，不可徒治疝瘕，因疝瘕不急于霉毒焉；如已形恶候者，亦当先顾疝瘕。

一闲齐门人桥诰顺治一婴儿痘疹入眼，久未退去赤翳，用生地黄、芍药、川芎、当归制剂，日就愈瘳。是与余谓四味缓肝、润肝、疏肝、泻肝分取，其治肝病同出一意焉。

伤寒误下成结胸，用陷胸法者，是误下。乃下不及病之意，故陷胸法再下之愈。(拙轩曰：此言未有见到者，曷能道之，误下误于轻下。正文原是失下，千古无人敢作如此解。)承气汤攻霉有捷于汞剂。

患瘵疾便先溲者，建中剂可用。便未溲咳嗽晡热喘哆痰多者，非建中证焉，投之反剧。

瘵瘵勿必由虚起，体质实者遇折伤久延，疮痍久不收，亦致瘵瘵。然亦实者成虚也。

伤寒七八日不大便，小腹高突者，为恶候。

大津小野又三郎者，患天行愈后，症似瘵瘵，咳嗽盗汗。余与地黄剂，众医强欲用建中，五七日遂喘急，仍与地黄剂愈。(拙轩曰：建中法必在瘵疾便溏者用之。)久患便溏，到皮色皎白，肌肉脱削者，瘵疾已成。

瘵瘵便先溏泄，艾圆灸天枢、膏肓、脾、关元亦愈。灸膏肓可三七壮，灸关元可五七壮。

发痫人艾灸当有忍心。

霉毒亦能致瘵疾。

瘵疾起时有咳嗽者，必失血。

余尝用薯蓣、生、加入四物剂，治愈妊娠呕吐便溏，患白带不止，形体瘦，癖结块在腹亦愈。

癖块食积胸膈，紫圆效。

打扑瘀结，大黄虫攻下即愈。余治一妇人打扑腹痛，月水欲来不通。萃冈青洲诊之曰：瘀结于腹，与余同，惟他药多剂不知。遂大黄虫剂，即见黑瘀行而愈。

痢疾不得进药为噤口痢，然积食不消，胸膈癖块结实，亦哿恶不可进药，勿谓一律噤口也。

婴儿吐乳，一吐直冲即止者易治。吐了再吐，吐出顺口而流也，不易治。当分别诊之。

伤寒失下多，误下少。

妊娠患伤寒当下之候，大承气亦可投。一妇人年二十有六，妊娠三个月有余，患伤寒已十日，手足冷，身热昏吃蠓，大便秘结，口燥气盛，胎动不安，头额汗。众医以白虎证用生石膏、知母、生、多剂未知，危已极，胸膈闷急，腹硬而痛。余谓承气剂可效，投之果愈。

(拙轩曰：有故无殒，此之谓也。临危之治疗，不可以有犹豫之意。不独治妊娠伤寒，如见他证，亦当如是也。)半身不遂，手足偏废于左为多。

痘证白色顶陷，保元汤效。

患霉毒者，兼发痘疮，多危候。

偏废症，亦有霉毒成之者。

中风证口开眼合撒手遗尿，亦有治者，余常用六君子加姜汁而愈。为市医者，宜审脉诊神而治。

伤寒病后，因劳而复者少，因食而伤者多。

余治伤寒有用承气法大便至数十行，犹见胶黑粘腻之粪者，岂可执一下不可再下之说也。(拙轩曰：断病确，然后用药准。虽一下再下，自亦无妨，然于诊断不可不加之审也。)喉痹多有急不及药者，若可进药，须急投之。

产后治法，市医必拘于生化汤。然亦有须审他证之急于去瘀生新也，不可不分别权衡。

产后中风，筋络拘急，手足蜷，四物合薯蓣、生、秦艽，补之则易愈，不可概作风治。腹诊似较脉诊有据，舌诊尤较腹诊有据。

先师东洞翁屡以紫圆治痰粘胶结气逆者，盖亦善用紫圆之妙也。然亦用之当者方效。

松原一闲齐治一妇人，年三十有余，妊娠漏下，用补中益气合十全大补两剂，早晚间投而愈。又治一妇年二十，妊娠亦患漏下，他医曾用过补中益气剂、十全大补汤，均不见效，闲齐用地黄剂即愈。盖一为气虚，一为血热，体质不同，治疗岂可不谛脉诊证而分别也。

桂枝汤治痹痛，亦能奏效。

脚气上冲，先师东洞翁亦用紫圆治之。

艾圆灸足三里穴，可引脚气不上攻。

疮疡用艾圆隔姜灸，奏效甚速。

桃花治痢泄，亦可通用。

黄胆证茵陈蒿汤不应者，合五苓散必应。

婴儿抽搐，不必一定，因风、因痰、因食、因热。如久患泻利，及大病后抽搐更多，与附子理中汤，每每奏效甚捷。市医有拘于惊风用麻桂各法，不救甚多。(拙轩曰：唤醒群迷，活人之功大矣。)艾灸之效甚捷，痹痛亦有不可艾灸者，霉毒痹痛多不可用艾灸。灸则反剧，当慎之。

按摩法宜于婴儿症，因其投剂易误也。

解毒剂治风疹见愈者，仍有霉毒夹症。

霉疮症身体强壮之人，虽勿投剂，火毒渐清。用当归、生黄、芍药各治肝药，每得愈。

患伤寒者投承气汤大下，反见舌苔黄浓而焦者，必当再下。亦有下后热反盛者，亦宜再下之而愈。市医多以一下不敢再下，但余见因下而死者少，失下而死者多。

龟背龟胸，由霉毒而成亦多。

瘰 亦有根于霉毒之作，不可不谛审也。

支饮易为肿胀，理中法合金匱肾气法得效。

余治一男子喘症，遇夏季必作，冬时反愈，与他人患喘症者相别。青龙法投之不效，香薷合六一散投之即愈。以治暑症之药治喘，盖其喘实因暑而起也。所以治病必求其本谓可信。征韩一役，患喘甚多，青龙法不效，惜乎未谛审及此。

卒昏倒汗出，肢冷，面现红润者，决死。

老人卒昏倒，脉见弦紧革等者，为恶候。如支饮亦然，其面戴阳者，尤为凶。(温公诗话云：平时充实而光泽可也，唯暴光泽特甚者，死兆也。是如草木将枯，精华顿发而生雀觴，司命者不可不知矣。)稟质强盛者，偶损下元，虚火上炎，加之以疫邪，医误为实，与大柴胡汤一下忽脱者有焉。余故曰：视色不以目，听声不以耳。

咳嗽有自心肺者，有自胃中者，不辨之，则治方无效。

腹痛诸药无效者，香苏散加青皮姜煎奇中，妊娠大腹痛者尤佳。(征韩役先哲既发明

之。而世医，实为可悯。)患瘰疾者，襟际肉先脱，与他病羸瘦不同，宜熟察。(拙轩曰：此诊瘰疾一大候，揭出示学者，可谓深切。按苏游传尸论云：此病若脊臂肉消，及两臂饱肉消尽，胸前骨出入，即难疗也。《灵枢·五变篇》云：臂薄者，其髓不满，故善病寒热也。东郭说盖有所原焉。)

久患痢癖者，瘥后其性躁者，为恶候。

遗精白浊属疝者多，概不可为虚，如强中病亦然。

下血有下焦湿热而虚者，宜茵陈四苓加附子。属肠胃实火者，宜三黄汤。肠风下血，肠胃中蓄水饮者，宜四君子汤加黄、白扁豆。胃中及下焦虚寒者，宜真武汤。如痔下血，亦可因此法通治。

甘草粉蜜汤，治囊病痛甚者效。

伤寒以大柴胡汤或柴胡加芒硝汤下之。热除后，肝气大动，谵言妄语如狂者，与竹茹温胆汤则安。世医不知之，妄下误治者多矣。

瘰成劳者，与痔漏成劳者，其理全同，但有上下分耳。(拙轩曰：不止瘰痔漏，凡疮口不收，脓水多出者，皆成劳，血液亏乏故也。)妊娠热郁甚则多堕胎，麻疹疫毒最然。此因肠胃热甚，熏蒸子宫，故用大黄、芒硝无所嫌，巴豆亦时可用，所谓有故无损也。但疫毒行下夺有机，不可忽诸。

两胁凝结者，直灸章门，则易激动。因先灸风市，则反奏效也。凡灸艾易激者，可善解此理。病在上者，先灸足，渐及腰，则上部宽不激动。因灸其部分，则奏全效也，是与大柴胡汤证候而阻其药者，反与理气汤利其气，而后事疏通则不激同理。灸药之于疾病，岂有二致哉。

妊娠下部有水气，至产后不瘥，恶露不下，气息促迫者，先利其水，则恶露亦通。治发狂用泻心汤紫丸者，夺取诸快利胸膈也。东洞先生治龟胸龟背以紫丸者，恐不过此意。产后脚膝痿弱与紫丸者，亦疏通胸膈气以下达也。

癖冲逆心下及胁下者，其所冲之眼必为邪视，又有因癖之左右而自异大小者。

妊娠呕吐不止，水分动甚者，小半夏，加茯苓汤、粳米、薯蓣、生奇中。若中气虚极者，香砂六君子汤加粳米，各咀为炒黑，别入洋参一分，水煎少少服之效。

暴吐血不止，或晕绝者，灸鸠尾穴数百壮奇效。(失血甚者，最要接续元气，不可畏

其炎焰，专尚寒凉，逐渐消伐其元气。)小儿吐乳不止者，对证方中加精品麝香皮效。(大人呕吐诸药无效者，麝香、桂心二味为末调服效。)马脾风、麻疹、丹毒三种，治法略同。而有马脾风异治者，如无价散是也。(此说太似粗，而细味之有理，精于治疗者自知之。)余尝读先生所着《伤寒论正文解》，深知其识见超乘于古人。又读导水琐言，养婴琐言，大见其治术入神品。特如方意解穿凿臆断，或戾古人立方之意，盖方论创于成无己。而吴昆、李中梓、柯琴、汪昂诸家，各有发明，然或有择焉未精，语焉未详者，方意之难解。振古而然，岂止此书哉。(拙轩曰：方意解一书极辨矣。要之一家言，仆亦不能信焉。)

卷上

荻野台洲

享和宽政之间，有以医鸣于京雒者二人：其一为和田东郭，其二为荻野台洲。台洲加贺人，学医于越前奥村良筑，后游于崎阳，受兰术于译官某氏。业成，悬壶于京师，最以治瘟疫着。当时四方之婴沉痾疾者，不踵乎和田氏之门，则凑于荻野氏之堂。是以二氏治术超越于时辈，独得精诣。悉出于实验，为临证处方之助，岂为不可哉？余乃就其门生所笔荻野家口诀者，编纂以作医话。如其识见，则有台洲园业书数种，宜就看而已。

温疫小便闭，烦躁或昏冒者不治。若阴证小便闭，少腹凝结，按之不痛者，或小便数急淋沥者，俱与加減真武汤，后兼用辰砂六一散，小便得节度则治。(按：加真武汤说见《温疫余编》。)温疫阴证虽不大便十日以上，不燥结者，不可妄与大黄。

温疫舌心干燥者，胸中有热也。舌本干燥者，下焦津液枯竭也。舌上白胎如着糊者，少阴虚火炎蒸也。白胎如鹅口疮者亦然。

温疫舌两端有白胎，中央胎已脱者，及舌上润滑如朱者，是邪热陷于少阴也。可直与生地黄，若用附子，则倍加甘草。

温疫热将解，小便频数者，热从小便去也。又有移热于膀胱而频通者，但热将解者，其色以渐清也。

温疫小血疲劳甚者，宜参附养荣汤。

疫后健忘者，宜安神益智汤。

一老人患直中温疫，头痛如割，烦躁，须臾不能卧，手足微冷，脉沉而数疾，与冷香饮子三帖，头痛半减。仍服前方，四五日全愈。

直中温疫头痛如裂者，肾厥之邪直逼于太阳经，故项背亦强也。一男子患此证无热，头痛如裂，一老医认为阳证，与大承气汤无效，更与柴胡清燥汤，遂不起，岂不浩叹哉。(按：台洲潜心于吴氏，于达原逐邪之剂，莫所不试。而阴疫治法，亦发吴氏未言之秘，可谓吴氏之忠臣氏。)膈噎者，以蓄血、痰饮、脾肾虚三者为因。因于痰者，饮食专噎于咽喉也，附子理中汤、旋复代赭石汤、二陈汤类加松寄生用之，且灸身柱为佳。因于蓄血者，饮食专噎于胸中，且以右肋骨下有块为标的也，以温脾汤送下乌神散，或二方更服亦可。因于脾肾之虚者，饮食下胸中，必觉摩痛，或食一纳口则吐白沫数口也，先灸气海。次与松寄生油，又宜服炙猪肉煮汁，若得食其肉者益妙，此证最属不治。妇人之膈多属蓄血，亦不可不知焉。

鼓胀自心下渐及于大腹者，实也，宜生姜泻心汤、大半夏汤。自中焦膨胀者，宜温胃汤类。

自下焦胀起者，宜壮原汤加木鳖子。此病以手鼓腹如鼓者，虚也，属不治。是为虚实之辨矣。血蛊者，自少腹胀起者也，先与生姜泻心汤，则其块徐徐消，然非长服无效。盖有血块必停水凝结，其块益为大，故先利其水而后治血分，则其效捷矣，或副用鳖甲丸亦一策。

脚气一证，以槟榔为套药，大概宜槟苏散加木瓜。冲心者，以童便服槟榔末，或紫雪五分，以童便灌下。此证多属不治。

热毒脚气者，以或有腹热，或其人自烦热，或灸之不堪热，为其征。凡灸之不堪其热者，多为冲心候。若脉数者，益危，不可忽诸。若脉缓者，无冲心之患。干脚气证灸之不甚痛者，无害，虽脉数亦可灸。

每年夏秋之际，患脚气者，宜肾气丸料风引汤(恐谓《外台》唐风引汤，非《金匱》方也。)类其人寒时预服肾气丸料，则至翌年不再发。

脚气麻痹及于口唇者，其毒深也。积年患之者，固无论矣。

脚气烦躁者，宜粒甲丸。

风湿脚气者，以疼痛为辨。疼痛者，必不冲心。若将冲心者，宜唐侍中一方。但痛轻者，宜六物附子汤。

云州侯(松江城主)患脚气肿满，侍医与以鲤鱼汤，虽小便颇利。其痛不可堪。因请诊为风毒脚气，服杜仲汤痛顿减，而小便日短少，其色渐赤浊。众以拟议仍连进前方，其病遂愈。

凡水肿与鲤鱼汤者，以腹大满为主，若不腹满者无效，小林大陵(京师医师)鲤鱼汤合苏子降气汤亦效。(鲤鱼治水病颇效。然脾胃不和，便滑呕恶者，不可食。按：范汪方有醋煮法，则为较和醋食当佳。)凡治水肿导水茯苓汤，以心下悸为主。若心下专有水气者，宜实脾饮，其他木防己汤、六物附子汤类，可随证而选用。

水肿证有小便虽不多通。肿气减者，盖水之所凑气亦凑。气一散，水亦减也。若内陷者，其气不振，故水不能流以陷于里也。欲振其气者，宜真武汤、牡蛎汤类。其人自阴jing阴囊肿者，亦虚肿也，宜肾气丸。

妊娠水肿随胎气长而甚者，胎压水道也，分娩则愈。

子痢者，与芍药甘草汤加干姜，副用童便可也。盖产前子痢与产后瘕无异，故又宜甘草干姜汤。《妇人良方》交加散，亦治柔瘕。产后之瘕病与豆淋酒者，以酒气缓筋脉也。此等法不可拘产后可，亦治杂病之瘕矣。

痛风以发表为先，务宜越婢加术附子汤，最后与下剂为佳，宜神丸。此证不泄下水毒，则无全效。(痛风热甚者，与禹功散无效，不如神之捷。)呕吐证与诸止呕药不应者，官参一味，五分浓煎。(以水二合煮取八勺。)去滓，伏龙肝末少许，取其澄汁服之。

吐唾不止，用安蛔药无效者，属《素问》所谓肾液宜肾气丸。又有属胃上寒饮者，仲景曰：喜唾久不了了者，理中丸主之是也。

胸痛证有痰饮，有蓄血。痰痛多在左，血痛多在右。属痰者清湿化痰汤、枳实薤白桂枝汤、控涎丹类选用之。属蓄血者，宜与大柴胡汤、龙胆汤、乌神散等。若妄投破血剂则吐血，不可不知。

真心痛者，饮麻油为佳。凡病属心脏者多不治。

霍乱多系于胃中停滞，故盛暑时减饮食则无其患。小儿中暑霍乱，尤自饮食发。馒头类不可食，乳哺者患之少，其因饮食可知矣。热甚危急者，宜与竹叶石膏汤、白虎汤。干霍乱者，宜大承气汤，不可妄与瓜蒂散，调理当用附子理中加桂、补中益气加附子类。

疟疾用达原饮加柴胡，其他九味清脾饮类，伍草果者最可也。阴疟别无治，方用达原饮类，迨病发于昼间宜截之。

左乳上痛而咳者，肺痈也，初起者宜四味薏苡仁汤、甘草干姜汤类。其人无故脐中腐烂出水者，属脾胃湿热，与平胃散加大黄，以赤乌散或奇良末贴脐中为佳。

眩晕有二道：因水饮昏倒者，宜苓桂术甘汤、奔气汤加茯苓类，盖奔气汤加茯苓主降下，更加附子推下之力反优，因气虚眩冒者，宜补中益气汤加附子。

心下有留饮痞硬者，生姜泻心汤主之。不痞硬者，宜茯苓饮、五苓散类。若留饮腹中有动气，或肾虚其气上冲者，宜桂枝、龙骨、甘草、牡蛎加茯苓汤。癫痫者，亦用此方。别有口诀赘焉。

血淋者，宜龙胆泻肝汤、八正散类。脓淋宜萆薢汤。石淋宜透泉散，又以琥珀油涂导尿管插入之于茎中，则石从坠。冷淋者宜生附散，小便已恶寒者，此方最效，鸡卵制芎黄散，亦治此证。

大便闭用鸡卵制芎黄散奇效。其方鸡子去白止黄，以芎黄散和其中炼，将包湿纸埋之于热灰中，以灰冷为度取出，去壳研末，白汤送下。

其人当右肋下有块者，必吐血。妇人经水不利而吐血者，属逆经，其血必黑，宜大柴胡汤，三黄泻心汤类。自肝藏发者属蓄血，其血亦黑，并用前方。自肺藏发者鲜血也，其血虽一滴难治，先与加味百合地黄汤、犀角地黄汤类为是。酒客吐血，属胃中蓄血，宜三黄泻心汤。

若不止者，属脾血，宜理中汤。盖下血久则脾衰失裹血之职，自然止也。独步散能治吐血下血，衄而属鲜血者无效。下血者，宜食海鱼，不可食河鱼。(按：独步散，干柿一味为霜服。)痢疾初起，以发表为紧要。若将噤口痢者，早可大下之，宜大柴胡加芒硝汤。禁口药汁难下者，咽以生萝卜汁，则得能下也。冷痢者，多属泻心汤，补中加大黄汤证，而附子之所治，亦往往有之。

咳嗽属阴者难治。横卧则发咳，仰卧则不咳者，水饮所为也，宜神丸。子嗽者，因胎气生长，水停心下而为咳也，宜当归芍药散。

泄泻无异证者，宜胃苓汤、补中汤类，又有养胃汤、藿香正气散、真武汤所宜。若食即更衣者，属脾虚也。轻者，宜补中汤。重者宜补中益气汤。久泻者，可理中焦，宜附子理中汤加赤石脂，或阿芙蓉丸。泄泻证多因不能泌别水谷，故宜分利水与糟粕。论云：下利不止，当利其小便是也。利小便宜春泽汤加附子。属中焦者，宜补中汤，或生姜泻心汤。泄泻愈后，脉迟细而弱，至夜半或黎明而泻者，此命门真阳不足也，宜七厘汤，或参苓白术散主之。又有属实者，宜大黄丸类。

嘈杂者，水气挟火也，宜三黄泻心汤、生姜泻心汤，但心下不痞者无效。(按：心下不痞而嘈杂者，宜旋复花汤，又吴茱萸一味煎服可也。《古今医统》云：嘈杂之为证也，倏尔腹中如火发，腔内空空若无一物，似辣非辣，似饥非饥，似痛不痛，而有懊不自宁之状，得食暂止者是也。可谓说尽嘈证矣。)黄胖或以为感粪土气，亦

非无理，何则？此病中人以上患之者绝无，中人以下往往患之也，宜皂矾丸。又男子脱血后，或女子薄血作此状者，宜四味补血汤，非皂矾之所治也。(按：因食粪发黄者，《本草图经》秦艽条引《崔元亮集验方》云：夜食误餐鼠黄亦作黄。识病捷法云：鼠盗饮食五谷遗粪在内，人不拣择误食，则生黄胆是也。)风毒肿多壮年者，老人甚少。两脚虽红肿不能自溃，先可发散，宜一剂散，后可下之，宜禹功散。治法大抵同于痛风。

病患有呼吸乍失调度。乍复者，不出五六日死。经曰：呼气出于肺，吸气入于肝肾。其失调度者，呼气不能归肾，上越于肝也。

心中时烦唇红，发作有时，时呕恶，闻食臭颧骨红者，属蛔虫，理中安蛔汤加甘草、附子。

反胃者断谷食，但饮白米饮与理中，大半温脾诸汤为佳。又有因水气发此证者，必心下悸，宜生姜泻心汤。(按：此证亦减饮。余闻台洲有减饮论未见，盖减饮事详见东坡集，与孙运司书，可参考焉。)穿踝疽不辨足内外肿痛者，宜杜仲汤加蝮蛇。病重者，副用禹功散。

解颅渐长大者，头骨开压额前肉也，当施绷带。初起者，宜六味丸加鹿茸，此方能治解颅五迟二证。盖本诸薛己之说。

蓐劳初起，宜当归建中汤。(按《千金》内补建中汤主治可考。)妇人肩背强急者，以坐药导带下则愈。若心下痞者，宜生姜泻心。(按：妇人肩背强急者，多系癖之所为，延年半夏汤最效。)喘息急者，半夏为末和生姜汁加曲服之甚效。

津液虚燥不大便而窘迫者，下焦气脱也，当升提其气，宜补中益气汤。若不窘迫者，宜六成汤。盖以补中益气汤无腹力，六成汤有腹力为辨。若六成汤证而无力者，宜加鹿茸。

竹叶除胸中烦热，竹茹主豁痰，所治各异。胸中烦闷者，梔子之所主。自心下及胸中者，黄连之所主，亦各有专长。

小儿夜啼，宜安虫散。(按：安虫散治虫动心痛，又小儿夜啼神效。胡粉炒黄，槟榔、川楝子去实，鹤虱各三钱，白粉一钱五分，铁器内火熬，砧杵，共五味为末。每服一字，大者半钱，温米饮服。)酒鼻严禁酒。时时以三棱针刺去血，可与辛荑清肺饮。

脑漏者，脑中酿热以出瘀涕也，古人以为脑移肺热误矣。其初流黄汁，后变白浊，甚者溢于咽，且鼻中点滴连绵不止，其状虽似清涕，以纸拭之，干则发黄色也，宜

脑漏一方，又似此证而鼻塞者，息肉也。其初生鼻中，渐逼鼻口，其色初白，次变桃花色，又一等甚者，色如李实熟，此证虽相似，以鼻塞与不塞为辨。鼻息治方见于方铃，又以瓜蒂末贴纸张捻条插入息肉上，则黄汁出而愈。

丹后宫津侯(松平伯蓍守。)平素无他病，鼻常流清涕不止，余以为肺寒所为，以大枣煎汁服皂荚丸，灸大椎第一间身柱，七日而愈。

症疮属表证，宜发表，杨梅一剂散加反鼻主之。其初与遗粮五宝丹等者，甚非也。

疳疮世贴膏亦非良策，但傅奇良未佳。(按：杨梅一剂散方见于外科大成。)疳疮发阴jing表者，为太阳经证，杨梅一剂散主之。发横面者为少阳经证，恶候也。

茎头上直筋不破溃为要，若破溃则其毒忽上于咽喉及鼻梁也，烛泪疳亦宜一剂散，兼用结毒紫金丹。

妇人妊娠十指麻木者，系血热所为，此证夏月尤多。轻者不及药，分娩则愈，重者与柴苓四物汤。

妇人多属带下毒者，不可不谛。

奔豚气属虚，支饮属实，其证相似，而其治迥异，可不精诊哉。

水势盛于外者，卫气之衰也，宜黄汤。

梅核气与半夏浓朴汤为法。然浓朴无真品，姑与生姜泻心汤可也。

杜仲汤能治脚挛急在右者，而不能治在左者也。

诊病患宜察眼中之了不了，与音声之爽不爽，此二者清亮则不死。

劳瘵与虚劳易混。虚劳之热浮泛无根据，劳瘵之热熏骨，而眼中甚了，不如虚劳之目中不了了也。四花患门亦治劳瘵，而不能治虚劳。又妇人虚劳者，经水早绝，属血瘦也。劳瘵者，有至病末末绝者。乃知二病自异也。

暴得痿病，腰足两股皆不仁，而不能步，脉滑而力者，先与瓜蒂散吐之，后以术附剂逐水则速愈。

雀目当审腹候。若少阳经拘急者，宜抑肝散类。若因脾胃郁热者，宜平胃散加大黄或黄连，又用鸡肝亦佳。

积年发小疮痒不可忍者，可与杨梅一剂散，加蝮蛇多量，外以西河柳煎汁浴之。此方亦治癣疮。

血燥皮肤为痒，及风热疮疥为痒痛者，宜当归饮子。凡一剂散证带血热者，非此方不能治。

漏风当背七八九椎际恶寒者，属气虚，宜补中益气汤加附子。又觉手足爪间有风者，亦属漏风一种，宜补中益气汤类。

哕逆因胃寒者，宜丁香柿蒂汤，兼用龙眼丸为佳。因痰饮者，宜橘皮枳实生姜汤。肺痿吐涎沫者，与甘草干姜汤，兼用皂荚丸。

鼻僻者，多发中风。欲防中风者，宜灸章门穴。

中风证气之所虚，痰必凑之，故以顺气导痰为治法，又中风未发时头痛者，肾气厥逆也，为不治。

病患服甘遂、大戟、桃花、大黄类，不下利反腹胀满者，当和胃气，宜甘草干姜汤加芍药类。

带下之块多在卵门下，(斥卵巢耶。)按之则如绵裹，觉温软也。又妇人脚痛属带下者，十有八九可详。

阴湿者，由谷气下流，宜减饮食，徐服萆薢汤类。若其证轻者，地黄、枯矾等分为末，和生姜汁贴之可也。

某侯一日垂钓于水滨，时有溺者自上流来，侯深悯之，命救之，几死。使侍医将一角末以管鼻，须臾吐水数升遂苏。台洲园有雉鸡误陷于井中，饮水数口，扶之出，殆绝。急将一角末五分，和水服之，须臾吐水霍然痊，乃知一角能解水毒也。

血证脉弦数者，有不测之变，可恐矣。

下利兼脚气者难治，以下焦虚故也。其他下部有旧疾而并脚气者，不可不虑。癫痫有因蓄血者，当卒倒吐涎沫时，必咯血乃可去其蓄血。一妇人有此证，新产后霍然愈，乃蓄血尽故也。

喉痹间有属胃热者，宜凉膈散类。

肠痈看法，往来寒热者属右厥阴，无寒热者属左阳明，是为左右别。又一种有二便

共闭者，为小肠疽，详于《外科大成》。夫病在大肠则大便闭，在小肠则便闭，在中央则二便共闭，理当然。而小大肠痈多在右，其在中央者形如硬块，或于小便闭易混，学人宜于活物上而活看耳。治方不拘三痈：宜选用如神汤，四味薏苡仁汤，大黄牡丹皮汤。又有阴证者，当行附子也，若与下汤仍不通者，痈发于肠中，妨塞便道也。

又便肠垢者，宜四味薏苡仁汤加大黄，最初宜如神加大黄汤。一等重者，为大黄牡丹汤也。

缠喉风与喉痹易混。缠喉风发于喉中深处，不可针。喉痹发于浅处宜针，若其肿深者，可吹入矾蚕。喉痹宜玄参、升麻，或清咽利膈汤，副用冰硼散。缠喉风即有一方主之。(按：一方未详，余与以驱风解毒汤加桔梗、石膏捷效。)血虚肿气似黄胖，其肿虽及右肘上不及左者，专在血分而不在气分也。古人以左右分气血，可谓不诬矣。

肺痈其初痛阴阴咳则引胸中。而其痛多在左，治宜在始萌。若至其吐脓如米粥，则百可治一二耳。

痘发热后不见点，通身肿满而死者，是表伏之证也，名曰肉胀。治方早与反鼻剂可发表。

齿痛宜当归建中汤者，外以黑砂糖擦痛处则捷效。黑砂糖亦贴阴囊癰风，并牛皮癣不堪痒者立应。

口肿有牙宣与胃热之辨，牙宣者，上齿或下齿必发于一方，而后波及上下，如胃热则否。且虽两证同出脓血，牙宣者脓多，胃热者少，是为其别。牙宣宜滋阴降火汤，胃热宜清胃加生类。骨槽风自胃热来者，宜杨梅一剂散。

妇人妊娠七月以上，当与当归芍药散，逐水理血，否则分娩后多患下利也。又产后下利者，多因肠胃为胎压制者，一时得舒畅而水气下奔也，不如乘其势与生姜泻心汤，以尽水气也。

产后咳嗽，多水浸肺之所为，其治与下利略同。

痛风者，风热入骨节也，可发汗。宜麻黄汤，桂枝芍药知母汤亦主之。表证罢，当以禹功散下之。

三井某年二十有余，腹中拘急，大便硬，饮食如常，但欲眠不能眠，来请诊。诊曰：子不能眠者，非心气之所为，其病在胃中。经曰：胃不和则卧不安是也。乃与桂

枝加芍药大黄汤，一剂而知，九剂而愈。

妇人积年有水块痛不解，或吐瘀液如淡黑色者，或如赤豆滓者，宜温脾汤，副用应丸。

若有蓄血者，右脉闭塞莫怪，是血结经也。又不论何病，右脉闭塞者，脾胃衰也。不可不知。

因蓄血腹大胀满者，与血蛊异，其证发作有时，或至夜而胀，至旦则减之类，与桂枝茯苓丸料效。

小儿卒下利发搐搦死者，所谓真中也，先与附子理中汤。余数年虽欲覃志焦神救活之，未得其肯綮。

吐乳者，专用治吐乳一方，此证渐剧摇头者不治。

急惊风者，宜桂枝甘草龙骨牡蛎汤。慢惊风因攻击发者尤属虚，可禁针，宜甘草、干姜，或芍药甘草汤、抱龙丸，《幼幼集成》用灵砂亦效。

诸病拘急者属闭证，仓卒勿错置，必有开期。纵使至死，一旦解而苏。

崩漏轻者，宜当归煎。重者，理中汤。其最剧者，加附子，兼饵食牛肉更佳。

芽儿衄血且鼻塞者，皆属胎毒，宜五香加大黄汤。又育不育之辨，大抵俟五十日判然。

详于《千金方》。

风水肿自面来。经曰：面肿者风，足头肿者曰水是也。

诸疮翻花者，因荣卫衰也，宜黄剂。又痔疾翻花者，胃气下陷也，宜升提剂。

痧病或以为《左传》所谓蜮，又云虫名沙工。吐沙人中之则为此证，此皆就沙字为说也。按：此病本自沙漠之南来，故名痧。犹痘自北虏来，因名虏疮。疳疮自广东来，因名广疮也。

不可深拘焉。

湿痹但痹而无痛，其初痿弱，后发拘急也。病在表者当发汗，手足屈而不可伸者，

宜四物汤加犀角、桂枝。

一妇人年四十余，左足肿膝大而痛，不能步行者有年于兹，来请诊。余诊曰：此证似鹤膝风而非也。鹤膝者，膝肿大而膝以下必瘦。今不瘦者，是带下所使。而其病在表，可发汗，乃与杨梅一剂散，痛渐止，更逐带下毒而全愈。

脏毒者，五毒郁热流注之所致也。其形状与痔漏类难识别，然痔发于肛之左右，而不关任督之脉，脏毒发于任督之脉，而不关肛之左右，是为别也。脏毒破血不止者，宜补血汤加干姜、附子，兼用独参汤。

风懿舌根如痿，言语不了然者，盖中风之类也。又有痰迷心窍，舌强而语言不如意者，甚相似。然风懿者属阴多不治，痰迷者属阳多治。其痿者与强者，其治自别也。

肝疡古来无明辨。此证肝脏中生疡，后见腹中，故不治。其初当脊之右肝脏之里而发者，或可治，宜透脓散。此病与流注易混，世医动以肝疡为流注误矣，盖肝疡比流注甚少也。

鳖瘕在右肋下而冒胃，按之则坚不痛，是属饮癖。不早治，则后必至胀满不可治，用白马溺为妙。

肺痛证《张氏医通》特论之。初起当中府云门而痛，后或吐血而死为难治。其初轻者，宜沉香降气汤类。稍重者，宜补中益气汤合生脉散。

肺痈痛而咳，肺痿咳而不痛，肺痛不咳而痛。肺痈痛在一阳者可治，在二阳者难治。(按：末二句难解，姑书俟考。)悬痈生于会阴之侧，多由湿毒，脏毒生于会阴，真中阴毒肿自会阴上斜向肛门之傍，脓溃如刀割状，三者相似而异。悬痈、脏毒，宜朴硝、石榴皮之剂，阴毒宜内托剂。

凡病患右身有所患，则当为血分治之，是为血证看法。

鼻痔瓜蒂，世之所知。湿家头痛者，亦以瓜蒂末点纸捻入鼻中，嚏出而愈。

小儿头疮为胎毒，治之无效者，因母有带下哺其乳而发也，速换乳母则愈。妇人头疮亦有因带下者，更与八味带下方，兼用坐药则愈。(按：八味带下者，系本朝制方，奇良。当归、川芎、茯苓、橘皮、金银花、通草、大黄俱八味。)吐乳胃虚者，宜附子理中汤、温脾汤类。若不愈者，与《本事方》青金丹。(按：青金丹治霍乱吐泻不止，乃转筋诸药不效，硫黄三两研，水银八钱，上二味铤子内炒，柳木篦子不住搅匀，更以柳枝蘸冷醋频频洒，候如铁色法如青金块方成，下再研如粉。)神仙劳名

始见董西园《医级》，(此书四部舶来、荻野福井各藏一本，余入江户。)此病盖因胃口蓄血而生，是以不食至数十年，蓄血能养胃气，故不死。用药亦非数年则无效，宜温胃汤、后以禹神散攻之。(按：医史丹溪翁传及垣赤道人吹影编。论似此证者，宜参考。)凡胃中阳气盛则不倾，若胃阳虚则必侧垂，水饮因乘之，名曰囊。然按之不应手，但以腹痛呕吐为征，宜温脾汤。若不愈者，服白牛酪效。(按：时还读我书续录云：荻野台州曰囊者。《医学正传》引东垣云：痞为窠囊者，用红花、桃仁。据此则囊兼蓄血，宜温脾汤，兼用血剂失笑散类。余尝观所吐物，与温疫蓄血所下物同色，故知其兼血也。)肠覃在脐下子宫内，几与胎相似。而经水将来，其痛不可堪者，服白马溺效。(按：用砂亦佳，后条可征。)砂能治产后腹痛。

带下者，其病从带脉下流，故名带下。盖其始水饮聚于冲脉，传于带脉，以入于子宫，与血凝结为带下也。故与生姜泻心汤去水饮，以坐药去凝结则愈。凡用坐药有法，深入子宫则其痛不可耐，若但在于阴口则无效，正在阴中，稍近于子宫处为妙。妊娠者三月后不可施坐药，固虽无害于胎，适脱胎则归其咎于此故也。(按：台州园坐药方，杏仁、甘草各三分，丁香一分，枯矾六分，片脑五厘，上五味为窠，三日一换之。)妇人淋疾，与露蜂房散有捷效。(按：露蜂房能酿乳，今与淋同其治妙。)崩漏与带下同因。盖水血混淆则为带下，不混淆则为崩漏也。

肝气厥逆为耳聋。耳聋者，以瓜蒂散吐之，后与柴胡清肝散类。若虚者，先与清肝散，候其实可吐之。大率百药无效者，得一吐必愈。

带下有成虚劳者，其初以寒热往来也。夫带下郁则生热，系少阳则成此证。子宫亦属厥阴，故睡觉时唇舌干燥也。

卷上

华冈青洲

青洲学识才力，较之艮山友松，不无轩輊，而专以精思攻苦，踵事涉历之，故其治术多出人意表。盖青洲次诸彦之后，熏陶之力固多，加之治疡之声，独擅海内，此其人与时为得宜也。

夫欲善外科，先宜精内科，何则？疮疡虽百端，不能出于阴阳虚实，苟审之而施之治法，则于外科无有间然矣。(青洲内外泛应，无不曲当。由其脉证分辨处，无不清晰。更由其内外合一处，无不贯彻也。)学医者，如宋儒穷理，不先格知人身道理，而后审疾病，则不能至极致矣。(拙轩曰：青洲翁常诵医唯在活物穷理之语，以教诱后进。洋学未辟之前，早着眼于此。故其截断之术，穷洋人所未穷之理。翁之于疡科，所谓斗南一人也。

失荣气瘰癧中毒三病，先哲以为难治，予亦未得其治。尝视桥本驿工匠某，左颈下发如瘤者，因论价者曰：此气瘰，恐数日后出血至死。果如其言。又视同病者，不过四五日迸血而死。如委中毒膝胫渐肉脱，骨尖黑蚀，恶汁出而死。世医动谓治此病审之时毒，就足胫而漫肿者耳。和州一妇人患失荣，疮未翻肉而口噤难饮食，试用五宝丹，肿稍减，口能食，而遂死。又一人与猛升汞丹，大瞑眩而病颇瘥，后再发至不起。

凡肿块有动气应手者，所谓动脉也，不可妄刺。误之则迸血便死。

世所谓神仙劳者，与抑肝扶脾散，莪棱为主，兼服辰砂散，或左金丸则愈。

肺部有毒者，必见数脉不可忽。若微咳带咽痛，或吐白沫脉数者，为瘵状，遂至死。蓄血下利者，不可攻，攻之则反促死。宜谛其腹候及舌色，千金黄土汤，或黄连解毒汤主之。

伤寒汗出恶寒，近衣被则汗益多，去之则恶寒反甚，数日不瘥。与柴胡桂枝干姜汤，桂枝加黄汤等无效。或谵语不食，终至危笃者。盖有二道焉：一则内热燃盛，津液溢表者，为越婢汤；一则表虚多汗者，为温经益元汤。(此证必舌上见白点。)一处女年七八岁，两脚痿弱不能立，右足心发水泡，其状如火伤，刺之水出，泡溃而外生红晕，按之微痛，经二日水泡及足跗浮肿，指头色点黑，此痿弱更不能流通血气，故为毒肿也。先与桂枝加术附汤，时时以紫圆下之则愈。(此即东洞先生衣钵，东郭先生亦续其传灯。)蝮蛇咬，内服乌头汤，及紫丸，外涂柿实汁则愈。

石淋非生会阴者，多生在阴jing中，割断去之，缝合贴膏，内插鹤羽茎补便道为妙。

手足创伤络喷血不止者，医或缝裁其络而血益甚，是与刺委中尺泽时缚其上际，则血愈出，其理同。

小儿解颅初起者，急与葛根加术附汤，兼以紫圆攻之则效。其证已成者，攻之则促命也。(紫圆能治上部毒，七宝丸能治下部毒，或以乾坤为二丸名。有理。)创家眼中见黄色者，脱血候。

咽喉创系气道者，小则治，大则不能治，如食道创虽稍大多活也。

破伤湿治方见《证治准绳》，然不如越婢加术附，虎杖茎汤神效也。(拙轩曰：虎杖根解散凝结，虎杖茎治破伤湿灸火热，见《青洲医谈》)脏毒看法，先控肛门谷道腐蚀为广阔，下如赤豆汁。其臭甚者，脏毒也。毒甚为翻肉者，多不治。

舌疳疔之可救十之八九，先割去其腐肉，用熏药为主。然腐蚀及齿龈者不治，癰

眼目紧缩者，瞳子散大者，俱不治。

乳漏久不愈者，始以祛毒膏为
，后以长肉膏换之，内服葛根加术附汤，兼用端的丸。

又毒凝结者，大黄牡丹皮汤，伯州散选用。

腐骨疽近胸腹及五脏者，不可纳，之则反见脱状。

眼胞或唇吻生疙瘩者，向里面取之为妙。

肿疡见流注状者，不论何因，与越婢加术附汤而可。(此初起者，至日久者，不割破去脓，则无治法。)黄瘰始萌以三候为征，曰眼中黄，曰心下痞，曰小便黄是也。虽身色如故，有此三候，则为确矣。又瘰愈以眼黄去为征也。

喘息剧者，麻杏甘石汤，或麦门冬汤，方中加没食子效。盖没食子能祛胸中胶痰，而世医知者鲜矣。(拙轩曰：治破伤湿以虎杖茎，治喘息以没食子，皆翁之发明。亦穷理中之事。)痼疾与汞剂以小量长服为要，譬之如晴天灌一壶水于地上，漠然无痕，以小酌屡注，则水自彻底焉。

走马疳，其毒甚猖獗，经日则烂龈腐骨遂至死。若初起口臭出血时，早施治则尚可救。

文化十年六月，一儿年八岁，患此证，其腐已及齿龈，齿脱三四枚，服以芦荟消疳饮，兼以人中白散，不出旬日愈，齿再生矣。

痘疹虽出于后世，其证之阴阳治法之温清，与痈疽无异。(许叔微曰：能医伤寒，则能医痘疹，能医痘疹，则能医痈毒。彼自伤寒悟入，此自痈疽入，道异而理同。名工所见略相同)。

风眼破溃出血不止者，犀角地黄汤，兼三黄汤效。血止而痛不止者，与通明汤，外施蒸药则愈。

妇人头疮久不愈，诸药无效者，与桃核承气汤，兼用桃花散则愈，涂桃仁油亦可。

冷痢误用疏涤剂，白脓反甚者，与东井和中汤效。

产后遗尿者，与参汤加附子效，盖方中益智倍加为妙。(又一方红花、洋参各一两，上二味，锉用鸢一羽去肠纳之于肠中，烧存性，温酒送下。)甘草干姜汤，能治自

汗、盗汗，其理与承气汤治阳明自汗同，此汤又治胸胁偏痛，此皆毒迫于心胸所致也。世医不知之，徒就汗与痛施药，宜矣不得其治。

产后暴泄与胃风汤速愈。若数十行后，心下痞满者，宜与生姜泻心汤。

或曰，走马疳疔之类或然，余视至其死者与疔无异。喘家以紫金丹攻之，则吐浊唾臭痰而愈。白散亦能吐痰，然彼专吐在肺管者，此专吐在肺府者，其部位自异。

解颅初萌，与葛根加术附汤，时以紫圆攻之则愈，若渐甚如斗大者不治。又小儿四肢痿弱者，用前方而愈，是其证异而其毒同也。若痿弱脊骨突起者，及左右证异如偏枯者，不能急愈。

凡欲用麻沸散，先与半夏泻心汤疏心下，而后不用之，则不能奏效。(此法自奥村叟吐法脱化来。)夫欲与麻沸散，宜审其证。若血色不爽，胸中有滞痰宿水，或心下痞硬者，不可与之。

先治其证候，而后不施之，则误人不鲜。又服麻沸散不瞑眩，则不可施术，误施术则亦害人矣。

服麻沸散瞳子散大，脉弦数者，是为瞑眩之候。

发痫角弓筋惕，气急促迫，或叫呼者，与甘草干姜汤效。

委中毒初发寒热甚，委中肿痛，后黑色腐坏，针之黑血出无脓气，膝盖肉脱，宛如天刑病，人证固属不治。

气瘤气瘰不可妄下手，反生害。

痉病初发，必两腮刚强，先与葛根汤，可针于合谷及发际则治。若见脱候者，十全大补汤加荆芥、附子，兼用豆淋酒加荆芥。然角弓反张甚，水药不下咽者，及口开者，不治。(传云：痉病握手者刺合谷穴，其深一寸五分或二寸，刺发际以浅为佳，铁针尤良。)破伤风其初项背强，或言语謇涩寒栗者可治，宜葛根汤、续命汤类，无患子、虎杖茎二味煎服亦效。若至角弓反张，则多难治，产后痉病亦同此法。

痉病脉浮涩为吉，若浮数者必再发。

一妇年五十余，患舌疳，其形舌傍疳蚀如翻肉，而腐烂及于齿龈，乃以腐药拔去其翻肉，服以黄连解毒汤，而外用熏药者，凡百日，余毒尽，病痊愈。

行熏药者，后不用下剂，则无全功。舌疳者，用紫圆。若由霉毒者，龙门丸主之。

近世患真流注者，甚少，今见流注状者，身体必为疮痕，与《外科正宗》所论大异。

一人年二十余，腋下漫肿，按之少痛，其状似痞癖，而其左足有疮痕，因为外因流注，与越婢加术附汤，时时以紫圆下之愈。

留饮兼蓄血者，非精腹候，则难得其辨。

鹤膝风或结顽毒固难拔者，宜乌头汤、桂枝加术附汤等，加角石。凡治毒难动者，为角石专长。

霉毒上攻凝结头项者，与桂枝汤，加茯苓、苍术、乌头、细辛、防风，兼用消毒丸。

苓桂术甘汤加附子，能治黄胖病。胸中有动气者，为铁粉、蜀漆主治。

疔施针刺，清水出者，不脓溃。血水交出者，必脓溃。脓溃者，反易治。

肠痔血出者，实证也，水血交出者，虚证也。

乳岩有经水者易治，经水断者难治。又乳岩者，怀孕则其核忽成大也。

胀满一证，有因水气者，有因结气者。水气者属实，故易治。气结者多虚，故难治。

吉雄元吉曰：患胀满而死者，茶毗之肠中一块凝然存，视之坚硬如石。西洋人曰：腹胀病动胀大管生如肉瘤者，四肢血脉为之妨害，渐至手足削小，或然。

狂痫血晕，其证相似而异，不可不辨。狂者妄语不止，痫者易惊，物剧至角弓反张。血晕，精神昏冒，甚者口噤，此证汗出脉无胃气者死。

狗伤外贴中黄膏加杏仁、甘草，内服黄连解毒，加木鳖子，兼食蟾蜍脰为良。

脱疽觉痛者，未腐蚀也。不知痛者，既腐蚀也。

淋疾为小便自利者，与参汤加附子效。

肩凝腰痛左手有创，右手有块，处处疼痛者，流注毒也。宜与越婢加术附汤，时时以紫丸下之。若虚脱者，宜参桂附剂。

金创在膈膜者，不论迟速必死，在脐上者为险，在腹者不用，近脏腑故也。

矾石、巴豆、斑猫、乌头等毒皆属热，故解其毒以冷水为佳。(按：天地间不论草木虫石，凡称酷毒者，皆辛热品也。故解毒药以苦寒为主，如黄连解毒汤、苦参汤是也。)腐药最为瞑眩，不可不知。一病患臀上施腐药，其毒忽上攻冲心死。

腐药瞑眩，其证微者，恶寒发热，或渴，或饮食不进。剧者烦渴或烦闷，其毒迫于心下，遂至促命期，急当救之。宜黄连解毒汤，甘连加石膏绿豆汤等。

产后战栗者，血气新虚，邪气袭之也。先与荆芥沉香汤，或与十全大补加荆芥、炮姜。

更虚者，又加附子。盖战栗至四五发者难治。然脉缓者可愈，紧数者为不治。

产后血虚，舌赤烂痛者，八物汤加鹿胎霜奇效。鹿胎霜亦能治产后下血不止者。

身体疼痛，概因血气凝滞，如金创天刑为痛者是也。故与行气剂则愈。

疝病根抵于少腹，故大肠下垂阴囊也。宜先辨其难易而施治法，阴囊偏坠渐肿大者易治，阴囊有消长而痛引少腹者难治。余尝遭阴囊消长证施针刺，则大便随下，不堪臭气，大困矣。又有因霉毒偏坠成顽肉者，宜以剪刀割去之，若贴腐药反害。

胃脘痛疑似肺痈而不止肺部，痛亦连少腹，吐脓血也，治法宜排脓散、桔梗白散。小儿发解颅者，其初必发热，牙关紧急天吊，宜先其时治之。葛根加术附汤兼紫丸，为得矣。若解颅证已具，多不治。

角弓反张无吐下者，急惊风也。搐搦上窜吐下者，慢惊风也，四逆汤、柴胡抑肝汤、惺惺散、清脾散。或的里亚加随证投之。后藤氏用柴胡加龙骨牡蛎汤，未知其应否也。急惊风则病间明了，慢惊风则病间似睡，以是为别矣。慢惊风则发以上必昏冒，多属不治。

偏枯不论老壮，可用桂枝加术附汤。其急迫者，以紫丸下之。诊其腹不拘急者可治，拘急者不治也。是气不能循环者，故虽下之，拘急不解也。

中风偏枯发作有时，多属痼家，桂枝加苓术附汤时时以紫丸下之。药不久服则难治也。

又妇人手臂屈伸不止者，痼也，大七气汤治之有奇效。(拙轩曰：以上数十则，尽是实际实语，翁精神之所注，百读不厌，学人宜奉为金科玉律。)往年门人服部方行，(字子执。村上医员。)喜先生说，就其书中抄录之，为叙其略曰：先生医术内外理，随证应变，浑从实际来，故方有准则，术有活用，后学不可以不研究焉。因请正于余，时方行婴脚疾遽没，后余有此着。乃删润其稿以表遗爱，且系以小诗云：多年曾乐与余游，岂计遗忽一秋。残月当窗人不见，满天风露滴空楼。

卷下

永富独啸庵

独啸庵能脱洒风尘，义气慷慨，似不屑医。而至其失鉴误治，详录以为后图。是以年虽未满强壮，治术多可见者，今就其遗着钞一二云。

痢疾初起，尤可重发汗，而俟邪气聚于胃，与大小承气汤为得也。(按：疫痢汗下之机，最为紧关。其初发汗彻透，则十可治七八。若里证不失下剂之机，则痢后诸患无起，误其机则多至脱候。)伤寒二三日，脉沉数，虚里如奔马，或心下痞硬者，后皆为大患。

病势缓者，死生易审定，如劳瘵、膈噎、鼓胀之类是也。病势急者，死生难预决，如伤寒、麻疹、痘疮之类是也。医须精苦，勿误此机。

癫痫固为难证，而男子精欲未发者，妇子天癸未至者，灸药得当，则十可治四五。但禀之于先天地得，决为不治。

家猪胆通壅滞，下逆气，功不让熊胆。熊胆多膺，非精鉴者不能辨也。(拙轩曰：按诸胆功用相均，牛胆猿胆亦可代用，胜膺熊胆远甚。)韩参润渴下气，其功过诸药。而世或谓韩参制焙失其性，不如芳野之产，可谓冤矣(余闻之对马人韩参肥大长四五寸者，人含之则走不必喘，虽冒烟火亦不为熏杀。又闻插花者，言采牵牛花，咀韩参传其茎中，则不急萎。盖韩参当暑月浸诸瓯水，俄而喷出泡沫如浊酷沸之状，故用之足以见此说之确矣。)今世患霉毒者，多兼气疾。故处方不兼理气之药，则毒瓦斯凝而不散。

淋疾痔漏亦因气发者不为少，攻之兼理气之药可也。

痿初发，其人无湿毒及瘀血之诸症。而心下痞硬弦急者，是为气疾，宜吐之，而后服泻心汤为佳。

劳瘵不可治，似劳瘵者可治。膈噎者，不可治，似膈噎者可治。世医动谓能治之，盖其似者耳。

吐血因酒者易治，因气者难治。一发尚可，再发多死。吐血后见肿者，危矣。

人多思虑，火易动，火动则津液涸，加之恣欲，则为肾劳，肾劳亦多气疾。气疾为痿者，其阴多先缩小，及其将愈，其阴先舒畅。

霉毒禀于胚胎者，决不治。假令一旦得痊，后必发。为人父母者，可不慎之于其初乎。

痉病有表证，而手足拘挛瘫痪者，以葛根汤发之。表证既去，拘挛瘫痪不休者，与大柴胡汤而愈。

中吐泻，手足厥冷者，有二途、一宜四逆汤，一宜白虎汤，医应湛思诊之。(霍乱热厥冷厥之辨，亦宜审之)。

《金匱》胸痹心痛之治方，多用桂枝、附子。而浇薄之世，民众黠而多欲，以郁蒸气火。故可芩、连者多，可桂、附者少，宜详其证候而勿误之。(仲景门墙之外，别辟畦径。非精思治术者，孰能为之。)产后血气易涸，寻劳伤精神，则舌干、泄利发咳为劳。又新产时恶露不全尽，则凝结上冲舌烂，泄利发咳为劳。(劳说二途，诚不磨之论。专门产科恐未能明悉此义。)伤寒二三日，心下痞硬，脉沉数者，后为大患，可微吐之。(伤寒行吐，不可过二三回。得一快吐则止，用瓜蒂三分若五分。其治一逆，则急者促命期，缓者为坏证。)伤寒与承气汤不得下者，当行吐方，而后再下矣。(此谚所谓欲得南风，先开北牖之意。尿闭亦有此法。陈修园曰：譬之滴水之器，闭其上窍，则下窍不通，去其上窍之闭，则水自通矣。用补中益气汤或吐法甚妙是也。)伤寒外证已解，胸中有停痰宿水者，微吐之。

月事积年不来，心下痞硬者，及淋疾浊证心下痞硬诸药无验者，当先与吐方，而后服对证药。

痿初起，暨病将发者，其心下有痞，则先吐之为佳。(荻元凯曰：暴得痿病，腰股两足皆不遂，脉滑而有力者，宜先与吐方，而后用乌附剂。)欲决病之治不治，定死生之期者，当审腹中虚实。凡候腹之法，如易而实甚难，何则。

有如虚而实者，有如实而虚者，有因邪而虚邪祛而实者，有因邪而实邪祛而虚者，其决得于手而应于心，父不可以喻子焉。

水陆草木之花实不一，有乍开乍落者，有倏花倏萎者，有花盛而无实者，有无花而结实者，有花小而长存者，有花大而乍落者。疾病之染人亦如此，医当察其开落之机，慎芟刈之期。

医为病制，则虽药峻剂大，其病不易治也。医制病，则虽药慢剂下，其病可治也。医宜谋诸未病之日，征诸既病之日矣。(拙轩曰：医为病制，医制病，语极妙。医书中无此文本，学者免为病制之医则难矣。)阅诸病者，不治而自愈者，百人之内不过六十。其余四十，十人者必死证，十人者难治，十人者险证，非良医不能救，特下工所疗者，十人耳。世医不知此区别，漫忽施治，取狂妄之名，遂归罪于古方，何

不省之甚哉？余奉古方以汗吐下之方疗癫痫、劳瘵、喘息、鼓胀、膈噎之类数年，始知此区别，诊视不迷，左右逢源。而后信古人之技，不在既病，而在未病也。

卷下

惠美宁固

独啸庵游艺州也，专讲吐方。始学之者，为奥文叔，其次为惠美宁固。宁固亦与吉益东洞切古方，别为一家。其徒所着宁固医谈吐方私录，吐方撮要，斑斑可以征古方之盛焉。

净心诚观曰：四百四种病，以宿食为根本；三涂八难，以女人为根本。又南海寄归传，载断食疗病。据之则食之一途，为病最伙，而吐之一法，祛病最为快捷方式矣。(拙轩曰：百病饮食为本。人唯与口谋而不与腹谋，故往往致灾。将食，问诸口曰可也，问诸腹曰未可也，乃止品从腹，从而后下箸，此是养生第一义。上出广瀨梅墩涂说，虽不关吐法，语甚有味。)水气妨气道，喘急肿胀者，宜镇气道水气，越婢加术苓，木防己加苓，兼服石中黄丸为佳。

食欲之害人，甚于色欲。而世人徒知色欲之害，不知食欲之害，悲夫。

小儿疳眼，大人雀目，皆因胃中宿毒，妨害精气之运用。小儿早断乳为饮食者，此证最多。按其腹必满，故祛胃中之毒为要。

伤寒病胃实，与水结易混。而水结证有宜下剂者，有宜附剂者，舌胎脉候，当精思甄别。

消渴有因霉毒潜伏者，不可不知。

因阙逢(方名)瞑眩而口中腐烂者，将严醋少少咽下为佳。若烦渴热者，白虎汤加黄连。

咽喉及口中痛者，甘连汤加大黄、桔梗。

天行热病，两手或舌上动者为凶候。(此证有发痫卒厥而死者，不可忽视。)病后发秃落者，贴蒲黄霜为佳。(拙轩曰：此证反鼻霜麻油调涂患处亦佳。)小便闭者，瓜蒌实二钱为散服效，此理可玩。

狂、喘、劳三病，皆属胎毒。毒攻心中者曰狂，攻骨HT者曰劳，攻胸膈者曰喘，其根同而枝叶异也。若狂愈而为劳者死。

大便闭与巴豆、大黄等不通者，他药中加木香效。(按三和散中木香即此意。)渴有因水气者，有因热者，又有病将解而发渴者，可辨。

伤寒有自得吐者为佳兆，若不吐则为结胸，若欲吐不吐者，可与一物瓜蒂散。

动悸有因气血凝滞者。凡血气之所凝，皆为动悸，不止心下也。

喘家不可妄吐，苓桂术甘汤加苏子、杏仁佳。

发秃落宜苓桂术甘汤，雀目亦与之，盖此二证为同因，何则？水气凝滞于头中，毛发不能为之荣，故秃落，水气壅遏于上部，精华不能为之注，故晡时失明，其理一而方亦活。(拙轩曰：融解贯通，圆机活法。)黄胖其因多属胃中不和。爪甲白剥者，胃气不足，气血不能达也。

一男子头并两手振掉不止，得之二三年，腹中和，饮食如故。余谓仲师所谓四肢聂聂之类，与防己茯苓汤愈。

和胃汤本于芍药甘草汤，故任脉拘急者与之尤效。若不瘥者，为建中汤，盖此证疑似柴胡汤。然柴胡专系心下，此方全涉腹中也。

山锡杖一名土山母，主瘀血痛，故能治产后手足疼痛。

小便闭，先与调胃承气汤加滑石为得。(按：鸡峰方治大小便不通，烦乱，四肢渐冷，无脉，以大承气汤。此即通后窍而前窍自开者，此方即系前后双解，亦一手段。然施之于虚惫溺闭者，恐生大害。金匱八味丸主治，宜参照耳。)阴狐疝多难治，而葫芦巴丸能治之，予近得之于江都医人稻村三伯者。

治舌疳椰子油一味煮沸，以木绵浸之，色黄为度。将其绵贴疳上，以烧针熨其上。日二，以不堪其热为知。内服凉膈散加石膏，时时与豆黄丸下之。(拙轩曰：此方奇甚，他日须试之。烧针直刺疳上止腐蚀者，予亦屡用，十中可治三四。)鼓胀、劳瘵、阴狐疝、膈噎、天刑、喘息、肺痿等，概属不治，故不敢下手。

反胃先与柴胡泻心汤、陷胸汤等，疏其胸腹，而后与吐剂，则全愈。

远年患腹痛者，吐之则愈，又安中散加姜黄、苍龙丸奏效。

漆酒治瘀血痛，其效胜于起废丸，又能治旧腹痛。中其肯綮者，必发吐下。

凡欲行吐方，先审其腹候。其心下坚实者，与泻心、陷胸、柴胡之类。制其胸腹之

毒，一二月或三五月而与吐剂为得。不然，则吐方无效，且不堪瞑眩也。(土生昌有尝从宁固受吐法。其说曰：凡用吐剂，先与黄连解毒汤，六七日而后用之，诘朝啜热稀粥一碗，禁午食。

瓜蒂散六分，以豆豉汤送下，少顷为吐。吐了，又与瓜蒂散如前法。又吐了，更服盐汤一碗吐之，又将拈纸探吐。凡吐四次，始药力达肯綮而后徐徐进热稀粥一碗，又与黄连解毒汤六七日，或兼用滚痰丸。此吐法之大概也，宜参用。)心下有小块，或病毒妨气道，短气者，不可吐。

服峻下剂以平旦为是，前夕宜减晚餐，其明服之。若食谷在胃，则反发呕吐，无药效。

如微下法，则非此例也。

用瓜蒂散(瓜蒂三分，赤小豆三分。)亦以平旦为是。服毕将吐者，一人持其首，一人按其章门穴，以要快吐，吐时宜少俯首。其人呕气不止者，药力在中也，宜强吐之，或盐汤促之。

胸中烦闷者，必发吐也。若欲止者，与砂糖汤。若病不瘥者，又当与独圣散三分。(此机非熟达者难施用。)凡服瓜蒂散后下利者，为吐已之候。又发渴者，及舌上发黄黑胎者，为毒尽之征。吐后一日禁食饵，至翌日少与糜粥，不可遽食膏粱油腻，若犯之，滞食至死。

淋疾小便难通者，蚕砂二钱，滑石一钱，甘草五分，煎服顿愈。

老人患淋疾四五年不治，或至死者，是积年之毒，流注于膀胱也。其治在胸中，宜三黄泻心汤，加阿胶、滑石，兼化毒丸。

淋疾先施对症方药，外以手巾浸热汤蒸腰眼八边，又将阴jing插入竹筒中蘸之于热汤中须臾，欲小便时，以手摩擦小腹通之。(所谓泄闭术。)一蒸一擦互施之，下焦气运，小便分利。

不然，则虽服药无速效。

《千金》漏芦连翘汤，以芎代漏芦效。大黄牡丹汤，亦以白芥子代瓜子，白芥子能散血故也。(按《圣济总录》大黄牡丹汤，用消石、芥子，名大黄汤。与此说暗合。)《外台》桔梗汤能治肺痈始萌者。虽证候未具，口有腥臭者，用之尤效。败酱或代葶苈。

小儿阴狐疝者，水气着经络注阴囊者也，附子、茴香、甘遂之类，为末服之效。

小儿喜食HT炭或壁土者，轻粉、砂糖，等分为末，糊丸服之，消痞饮紫圆亦效。

小儿耳，独圣散点入于耳中，则黄水出，即令儿横卧，去其毒水。

哑者，系胎毒壅闭上部也。耳不聋者可治，聋者不治。

小儿初生，汤药不能下咽而溢鼻者，为恶证。

小儿惊风，角弓反张欲死者，红花、郁金等分为散，以新汲水送下得效。

生儿两手动，如弄傀儡，脐下左边拘急者，与《千金》陷胸汤，兼用紫圆速效。凡毒着胸中者，陷胸汤主之。

胡黄连能解胎毒，故古人往往用以治小儿五疳，今甘连汤加之特效。(此品本草云：治女人胎蒸消果子积，亦可活用。橘宗仙院以此品一味为糊丸，治妇人恶阻不止者，亦奇验。)妇人赤白带下，其病多根柢于心下。故与三黄泻心汤，加阿胶、滑石，兼用化毒丸。

凡不论男女，中年以上，肠胃生癖，腹底如石者，及平生舌生黄黑者，若得新病。虽轻浅，荏苒延日，治之有法，当先治其新病。若误攻其癖，则反生大害。若新病瘥后，其症可攻，则当治其痼疾。(仲师先治其卒病之旨，其说最着明。)妇人前阴生虫者，与汞剂效。(此恐阴虱，俗擦以轻粉速愈。)妇人阴门大肿者，龙胆泻肝汤效。

妇人经事不调，因饮食者，多下白浊污物宜审耳。

一妇人崩漏百余日，众工束手，余与茯苓四逆汤加浮石愈。

子痫世以为胎中子病，误也。此证多因催生水毒冲逆者也，故与瓜蒂散吐之则分娩，而其证速愈，又与《千金》陷胸汤、熊参汤可。盖此证与产后痉病相似而大异。

妊娠恶阻，饮食不下，诸药无效者，宜桔白丸。(恐桔梗、白散为丸者。)难产者，得小吐则愈，是升降气通故也。世医或用鹿角菜、云母，余概用瓜蒂。

一妇产后肿胀数日，气息促迫，喘满绝汗，小便不通，食不进，众医以为不治。余谓留饮之所为，与甘遂半夏汤一服，淡水吐出，须臾泻下如倾，诸证渐愈。

一妇平生便秘，心下动悸，加之头热不堪风寒，耳前后生疙瘩。疮痒难忍，历三年而不愈，与反鼻解毒汤、芎黄散安。

产后胞衣不下，气逆吐臭沫者，多死。

产后血晕，有属水气者，不可不知。

产后失心不省人事者，得吐则愈，又有宜附子泻心汤者。

膈噎壮年者可治，四十以上者必不治。

膈证心下结块，累累如拳者，为恶候，又舌上发紫色斑者同之。

人过强仕而发膈噎者，此年来宿毒凝结于胃中，渐上迫塞于喉间，胃中为之萎缩顽固，按之自心下至脐下，如抚竹筒也。此证误与吐剂，则不堪瞑眩速死。世所谓肺痿肺痛，间有属胃口留饮者。今以吐剂涌之，脓血粘痰多出于食道，不可概为肺而治之。

鼠毒散漫周身者，必发热，宜刺委中、尺泽出血。

中砒石毒者，与白虎加黄连汤，饮冷水亦佳。

桔梗能内托疮肿，治咽喉痛，亦不过此意。此品生干尤效，水晒者无效。(本草称苦梗者，恐是生梗。)桦皮能排毒瓦斯，永田德本多用之，曲直濂道三亦使之。(桦说见本朝医谈青囊琐探未确，宁固单用桦皮近是。)(拙轩曰：青洲翁荆防败毒散加桦皮，名十味败毒散，为诸疮套剂。盖本此。)仙人草专治口中病，故泻心、陷胸等方中加之妙。

胀满鼓胀，其发非一朝一夕之故。若病欲解，发大热，或发谵语者，为吉凶之界也。

胀满鼓胀绝谷者，与赤小豆、薤等间效。

五宝丹能治痿，不可不知。(世医以五宝丹为专治上部结毒之药，故有此言。)舌疳难治，但痛者可救。

吐血下血色黑者不可止，鲜血者可止，灸命门捷效。

健忘属蓄血者，宜抵当丸。

头汗多，因胸中逼迫，故结胸类必有之。

脚气冲心，与控喘(喘恐涎字之误。)丹效。

脱肛不愈者，食鳖顿愈。若愈后发咳嗽者，遂成劳状死。

张子和曰：水病脉洪大者可治。余验之，洪大者，属实可治。若弦滑者，必有急变。

婴儿顿嗽，与左金丸愈，蝙蝠霜亦效。(蝙蝠霜名独圣散，片仓鹤陵用鼯鼠霜亦效云。)一士人年三十许，项背强直，不能回顾，背肋牵痛，右肋下硬结如伏卵，扪之不堪痛楚，其状如木偶，起居动止皆废，众医治之无效。余诊之曰：他年肉食之所毒，不祛宿毒，则不能愈。某曰实然，去年役于江户，屡食野猪尔，后发斯患，因以陷胸汤、桔梗白散吐下之，寻与国木汤加土茯苓全愈。余常以土茯苓解肉毒，故加之。

小儿痘后，颜色萎黄，吐乳者，上焦郁毒未解也，与紫圆三丸，日三服愈。

救急易方以蜗牛水治消渴，余乃治消渴用蜗牛霜，反便捷奏效，因名三国散，取之于庄子则阳篇也。

一夫得病二三年，头面及两手大战掉，胸腹无余证，饮食二便如常。此病在络者，古人所谓四肢聂聂动也，宜防己茯苓汤。

霍乱不止夏月，四时共有之，小儿尤多，大抵理中汤主之。(按外台有冬月霍乱字，可征焉。)产后痿为难治，初服乌头桂枝汤，寻用荆芥汤而已，或间服汞剂效。

一妇乳岩肿起颇难治，一夜梦友人来告曰：宜当归生姜羊肉汤。余从其言用之，大托脓血，因兼用于阙逢丸、梅肉丸等全愈。(羊肉吾邦乏用，今代用牛肉。)水肿坚实肌表见紫黑色者属实也，宜发汗。一人年五十许患此证，余与麻黄加术汤发汗，数日全愈。

水病急大汗出，或急泄利，或急肿减者，反为恶候，不出四五日死。又有医数下之，续为大下利。肿气急减而死者，盖治水气之法。譬之于倾满盆泥水，急倾之，则滓泥必着盆底，缓淘以倾之，则水与泥滓同去。故与汗下之药要缓攻，若急攻之，则病去身毙，不可不慎焉。

仲师曰：水病脉出者死。譬之于溺水者，有生气者必沉，既死者必浮。其元气衰者，脉自浮；元气不衰者，脉自沉微。故水病脉浮滑为凶，沉实为吉，圣训千古不磨。

也。腋臭及耳有脓者，皆属胎毒。

过酒后吐下或心下痛者，葛根黄芩黄连汤有效。(按：《伤寒论》酒客病，不可与桂枝汤条。柯琴注云：仲景用方慎重如此，言外当知有葛芩连以解肌之法矣。偶与此符合。)下后心下痞硬，不能食者，茯苓饮尤效。(按：吴氏曰：疫邪留于心胸，令人痞硬，下之痞应去。今反痞者，虚也。以其人或因病先亏，或因新产后气血两虚，或禀赋娇怯，因下益虚，失其健运，邪气留止，故令痞满。今愈下而痞益甚，若更用行气破气之剂，转成坏证，宜参附益气汤，此与茯苓饮证相反者。若误投之，祸不旋踵。)肺痈吐脓血，胸中痛者，与对证药兼服伯州散则愈。

雀目与苓桂术甘汤加车前子为佳。

缩砂投酒中，酒忽化为水，故能解酒毒，又并消食也。

中河豚鱼毒者，可以蓝汁吐之，染匠新制者最宜。凡中毒，吐药为佳，蓝汁即其一也。

凡服吐剂，自辰牌至巳牌为佳。服下剂以人定后临卧为佳，利水之剂亦然。夫人日中百事纷错，元气为散，入夜安卧，精气下行，故通利之药，最宜临卧也。

小儿常食多好恶，日羸瘦腹满者，由膏腴之毒，熏蒸肠胃，故腹满、肉脱，饮食为好恶也。治法宜驱肠胃之毒，流通津液。古人用消痞汤，亦不过此意。然此证多属不治。

平素健啖者，有忽发身体强直或不遂者，不可妄药，但减饮食，则必自愈。(宁固曰：病多成于食毒，专用吐剂，而于此证云不可妄药，高出前人一筹。)衄血诸药无效者，三黄泻心汤中加荆芥二钱奇效。(按：《卫生家宝》治血气妄行，其出如涌泉，口鼻皆流。侧柏散，侧柏叶、人参、荆芥穗共三味，此亦荆芥为效者。而其治虚实相反，并存而可。)

卷下

福岛慎独轩

慎独轩尝受松原一闲斋衣钵。林栖于芳野数十年，志不拘检，神情旷荡，无甚可否。是以前理疗，自然融活，不似当时古方者流所为。门人中川，故能记其成绩，着《芳翁医谈》，其可谓翁之忠臣矣。

凡腹中有块而发挛急气急等证者，不论血块积聚，与起废丸效。

其腹有块而腹里拘急，形体瘦削者，名曰干血劳，起废丸长服为是。

反胃难治，然驱除停饮，和胃气则得愈，宜长服小半夏加茯苓汤，时时以大黄甘草丸除其腐秽。

中风卒倒者难治，与附子泻心汤间得效。

偏枯言语謇涩者，与麦门冬汤加石膏。但偏枯者，与续命汤。此证石膏最为主，一贴用至五钱。(偏枯用石膏，山胁东洋原之于续命、风引诸汤，翁亦同时同见，所以古方盛也。)(拙轩曰：麦门冬汤加石膏，似戾立之本旨，然用之往往奏奇效。古方之妙，不可思议。

偏枯瘫痪及痿 麻痹者，皆系阳气衰废，故虽用乌附之类，不能奏效。

休息痢因秽物不尽，宜服笃落丸下之，兼用半夏泻心汤之类。

下利久不止，其证如休息痢，而无脓血，唯水泻时作时止，腹满时痛，泻则觉快，日渐羸急，面色萎黄，恶心或吞酸者，非巴豆则不能奏效。故用笃落丸，兼服半夏泻心汤为佳。紫丸治久痢，亦此意也。

痢证百端，不可枚举，而眼胞脞数瞬呼吸促迫如喘之类，三黄泻心汤最效。若冲逆甚自汗出者，前方加牡蛎。若见诸怪证者，兼用辰砂丸。

痢家概治《千金》温胆汤为最矣。凡诸证变出不定者，皆系肝胆之气郁，宜主此方而勿眩其证妄易之。

上市买人之子，卒然厥冷戴眼，不知人事，予以为痢。与三黄加芒硝汤，三日不瘥，因请治于松原白翁，翁与风引汤三剂而全愈。一男子年十有八，素患口疮赤烂，一日直视不语，心下石硬，醒复发，予拟前治，与风引汤十帖，始知人事，后与三黄汤全安。

痢家舌焦或滑白如溃水者，内服麦门冬汤之类，外以黄连石膏末贴之则愈。

多罗尾候性躁拘物，患失精数岁，与人并坐而不自识其漏泄，诸治无效。予诊曰：此痢也，与三黄泻心汤全愈。

内痔难愈者，内有结毒也。宜驱尽其毒，皮最效，如痔漏亦然。长服下剂，可荡尽其毒，勿漫施外敷求速治。

病有不可不为者，如汗吐下是也。若失其机，则病不治矣。有为之而不若不为者，如鹤膝风、流注毒是也。何则？节脉有条理，而皮外不可见。故妄施针刺，则多害屈伸。若服托里之药，毒瓦斯外泄，终自脓溃，则无后患。余故曰：为之不若不为。治疮肿者，不可不知。

狗毒鼠，古今论其治，而至猫毒寥寥无闻。予尝为家猫所咬，痛楚苦恼，不可名状。

因普检毒兽咬伤之方，将水晶一味煎服，其病霍然如脱。后复发，乃作黄连解毒汤，加虎胫骨兼服之，数十日全愈。

余尝见磨古镜者，将石榴皮磨之，则银光剥尽为铜色，乃知水银之所忌。世解轻粉毒，专用石榴皮，洵有以也。

水肿冲攻，或脚气冲心垂死者，取巴豆一味去皮碎，与赤小豆合炒而去巴豆，赤小豆一味煎服之，则咄嗟奏效，或赤小豆汤方中用此品亦佳。

齿痛难堪者，宜桃核承气汤。(龋齿、疽、牙疳、骨槽、诸齿痛难堪者，余用之屡效，盖属血气冲逆者多故也。)一人患啾五十日许，众医束手。余审其腹候，与建中汤二剂全止。(按：洋说以啾逆为膈膜挛急所致，建中汤所以效也。盖翁非信洋说者，治术精思，偶诣此耳。)《外台》泻脾汤，治癖成劳者，世所谓积聚之类。有腹痛者，用此方往往奏效。

发狂者，与三黄加芒硝汤，兼灌瀑布泉为妙。灌泉法，使患者着HT，而以麻索缚之于梯，别以手巾覆其头，而后灌百会，又以手当额上御眼鼻，而灌天庭，次至胸间膻中，则其人易堪，而克奏效。(泉水浊者不佳，宜择清冷者。)凡漫肿坚硬，皮色不变，而其势甚炽者，以矾石汤蒸之，则能消散，悬痈、淋漏、痔毒之类最效。又治瘫痪不遂不止，脚气冲心也。

娼妇始入妓院，与客接十日余，必发寒热腹痛，俗称曰淫腹痛，海萝能治之。如寒热不已者，宜小柴胡汤加海萝。(按：《兰轩医谈》载海萝汤治验可征焉。凡海草能避霉气，故京师妓院多食青海苔。《大和本草》云：杨梅疮家食昆布，面不发疮，是亦其一证。)人中白能治血晕。不论产前后与金创损伤，以井花水送下少许，则晕立止。一妇人产后患口眼斜，半身不遂，余与桂苓丸料加沉香、人中白而愈。以血分有病，人中白能治之也。(产前后口舌赤烂痛甚者，以人中白贴之效，以能入血分也。)金创出血难止者，以纸条紧缚之，以淡红粉撒其间，随缚随撒缠毕，而妄动则血止。如其更甚者，敷矾石粉，痛发必止。

痢家有数证，而属火热者，属瘀血者，宜甄别舌上苔。其色或黄或黑，常苦上冲，

脉数而有力者，为火热，宜麦门冬汤加石膏、柴胡加石汤瀑布泉选用之，兼见血证者，为瘀血，宜三黄泻心汤，加犀角、芒硝，或沉香、姜黄之类。若手足螈者，宜天麻。间有妇人老后自愈，即与患痢之妇产后不药而自愈者，一理也。

噤口痢有宜半夏泻心汤加槟榔者，有宜真武汤者，不可概治。

妇人经闭成

痼者，成鼓胀者，灸肾大小肠膀胱诸俞及腰眼，至十万壮以上，则必效。

黄胖用铁粉而不效者，宜辰砂。

一人伤寒，瘥后久不食，众医治之无效。余诊之，腹中有动悸，与桂枝加龙骨牡蛎汤，食忽复故。

医有上工，有下工。对病欲愈，执方欲效者，为之下工。临证察机，使药要和者，为之上工。夫察机要和者，似迂而反捷，此贤者之所得，而愚者之所失也。

人生固有自然之理，而疾病亦不外于人身。故医审其理而治之，否则施治益谬，是以长沙氏之书务矫其弊，可不鉴哉。

卷下

田中适所

本朝八九十年前，越前有奥村良筑者，始阐吐法。而其门人永富凤介着《吐方考》，荻野元凯着《吐方编》，田中信藏着《医事谈》，皆绍述师说，所裨补不为鲜矣。

汗吐下异法而同归，可吐而不吐，同于可汗下而不汗下，而世医或遗吐之一法，故病处于不死不起之际者，比比有之。长门独啸庵特得其法，而其所着《吐方考》，皆有征验。

余从奥村先生学吐方，十余年而后行之。年不下数十人，颇知其效验。然至其机变，则非言之所能尽，唯考征已明，试验必审，精与识合，胆与信符，而后可庶几焉。凡欲行吐，当审腹候。按之不得其可吐之候者，虽上下坚实，不可吐之。

凡快吐者必快下，上窍开而下窍通也。而张子和更下之数十行，是宜权其势而斟酌之。

凡行吐法得之于缓病，而后得之于伤寒卒病，则远害矣。

癫痫者，以三圣散吐之，后与铅丹剂佳。

喘息腹满者，不可吐，宜回春紫金丹。若不满者可吐，宜瓜蒂散。

伤寒汗出不解，胸胁苦满，不食饮食，大便或利或秘，舌上白胎，短气而烦者，当吐之，瓜蒂散主之。失吐者死。

发汗吐下后，心中懊 结痛者，当吐之，失吐者死。(吐方或指栀子豉汤而言。)盐汤吐痰，地黄吐蛔，五苓散吐伤寒，葱白头吐头痛。此数方非能吐人，惟在知其义，对其证而得其法耳。

反胃诸呕，少腹有块动悸冲巨里，心中热痛，饥不能食者，不可吐，吐之必死。

汗出而后蒸蒸发热者，属胃也。若胸胁满而呕者，其热虽潮，未可遽下之。世医不知此机，多方误投，轻至重，重至危。悲矣!下利下重，虽脉洪数，当审其腹候。有宜汗，有宜下，有宜和，不可一概下之。下如鱼脑肝，食饮不下，脉细数者，数日死。能食而下脓血，久不已者，以肠痈药治之。

下利咳逆，痛引胁下，不欲饮食，寒热去来，欲为劳者，急下之，宜十枣汤。

医之临病，犹将之对敌。苟不得其时，不知其机，则一败涂地。思之必精，察之必审。而误者未之有也。书云：惟时惟机。天下之事皆然，不止医事也。

中风口眼斜，或半身不遂者，与瓜蒂散得效，若卒中风者无验。

痿多由热气上逆，故下焦气血枯燥，而至足痿。此证必小便频数，大便秘，后遗尿失禁，甚则下血而死。与吐剂而后与白虎汤为得。

耳病用宣明论泻青丸效。

被灸火发壮热喘息者，小柴胡加黑豆、牡蛎尤效。

肠痈经日属阴者，薏苡附子败酱散，加黄 佳。若痛甚者，加没药。

痘疮至贯脓时，烦渴闷乱搔搦者，与风引汤效。盖此证痘科键用满天秋，《活幼心法》用唇砂益元散，而不如此方最捷矣。(拙轩曰：运用自在，虽存于其人。古方之妙也，西土之医家，或乏此识。药方之日增月加，职斯之由。)不由邪气而口中干燥

者，属血虚，故虚劳多有之。发热亦有属血虚者，不可不知。

生姜发开心胸结邪，干姜温散心胸寒冷，使用虽多，不过此二端。世医无深知生干之别者，噫！休息痢属疟者，宜当归四逆汤。

噤口痢不能纳药汁者，鲋鱼为泥，和以吴茱萸，麝香少许，贴之于脐中得效。

食伤不吐下难奈者，升麻、郁金二味煎服捷效。

霍乱转筋甚者，与理中加石膏汤为佳。（古人治转筋以理中汤加石膏，治胞衣不下以平胃散加芒硝，其意难晓。盖阴阳相摩，刚柔相济，妙在其中。适所得之于实验，其言非虚矣。）

卷下

福井枫亭

枫亭医术自是高手，京师人传其起痼扶衰，悬决生死日时，多奇验。今就其门人所记医按提其要云。（拙轩曰：枫亭翁喜读《千金》、《外台》，故其论病说方，多本其书。于先辈着鞭之后，欲别开生面，不得不假手孙王二氏也，满清医人无此见解。）世有面色萎黄，肌肤干枯如老耄，眼多眵泪，鼻流清涕，气逆心烦，胸中怫郁。按其腹鸠尾至脐腹，任脉拘急如张两纽，按之则痛，动悸甚，脉多滑，喜饮茶汤，或吃杂食，每眠睡，心气懒惰，临事狐疑，或愤恚不乐，渐目下足胫生微肿，或中年夭折，或痼全生者，医以为黄胖，或以为痢，治之无验。特不知此病本因情欲不遂，饮食失宜，不胜其劳，遂蕴蓄湿热。其热熏蒸为面黄，甚者郁热消烁肝胆，忧虑恐惧，百事不决，昼夜不能眠，以致此病也。盖此证有虚实之分，肌肉敦阜者属实，身体羸瘦者属虚。虚证面部或足胫浮肿者无害，若实证历日，足胫目下微肿者，脱候也，为可畏，余名之曰脾劳（《千金方》所谓脾劳与此证大异，本草百病主治铁砂条，所谓脾黄病为稍近。）凡脾劳湿热泛滥于膜外为水肿者，宜圣济紫苏煮散。若郁热流于肠中，为脱肛痔疾者，宜润下剂。但便难者，宜脾约丸。若下利不食者，属虚也。若郁热侵胆府，则善衄。移热于肝脏，则善惊恐。热郁于胸背，则肩强。

左肋挛急，或咽喉不利如梅核气，或水饮客于冲脉咳嗽，或心下如盘，食不下时吐逆者，宜半夏汤（《外台》方）。若暖气吞酸心下痛者，宜四味枳壳散。盖此证郁热支冲脉，水饮不能为之流通，因心下悸。若认为留饮治之，反生害。但解其热，则饮自去也。若其人羸瘦，津液乏少。心下动甚，目下微肿，耳鸣目眩头晕者，属虚候，宜沉香降气汤。若热传于大肠下血见前证者，宜铁刷汤。若能食，下血不止者，宜赤小豆当归散。若下利腹痛如五更泻者，宜真武汤。若腹鸣下利者，宜半夏泻

心汤。若不下利，心下右边当委食之府痛者，香砂平胃散。若左肋下至少腹挛急冷痛者，柴胡鳖甲汤。若热熏蒸胸背，涌痰咳嗽，喘逆肩息似支饮者，宜九味半夏汤。若两肋急胀，腹满不能食，头痛壮热，身体疼痛者，宜延年枳实汤(《外台》方)。若旧年脾劳，冷热不调成癖，积食不下，虚满如水状者，宜前胡枳实汤。若性稟薄弱，忧思不遂，久郁不解，血液枯燥，往来寒热，盗汗咳嗽者，《圣济》所谓癖成骨蒸也，宜秦艽鳖甲散。若热熏蒸脾胃，及肝胆疑虑不决，心下如盘，舌上沉香色，其人如狂者，宜半夏汤加石膏。若心下痞闷，痛引乳下，或冲脉支结，胸中牵痛者，宜柴胡白术散。近世患此病者颇多，盖现证有全似他病而属脾劳之变态者，有他病为主脾劳为客者，能审辨之以处其方，则思过半矣。(此一种内伤病，脾劳名未知当否。然其反复辨症处，溯流穷源，其次第用药处得心应手，近患此病者最多。则其治法宜研究也。)中风病由，《素问》单云风，刘河间以为火，李东垣以为内伤，纷纭难适从。但《外台》许仁则所论似是，此证先宜与《千金》竹沥汤。若不能服汤者，用乌犀丸，可以开达咽喉。若胃气反逆呕吐者，百不治一。

一人年四十余，病温疫下血后，身重难转侧，四肢不收，口眼开脱，语言不出，其状如塑人，脉滑，舌上生芒刺，似欲冷冻饮料。余以为下证悉具，即投以大承气汤服之。一帖，眼睛活动，语言少出，续服前方全愈。又一人患同病，而精神稍爽，瞳子和，口中津液粘涸，不能语言，绝食数日，人以为死证。时患者动指，其状似欲饮水，因与之，少得语言，如此数次。余试与白虎汤遂愈，盖承气汤主精神昏愦，不能语言。白虎汤主精神爽快，津液粘涸，不能语言。虽均属里实，二汤之所主自判然矣。(《中西深斋名数解》有白虎承气，辨颇明晰。而枫亭得之于实际，宜彼此参稽处之无差误。)肺痿有冷热之分，而《金匱》但载肺冷治方，不及肺热诸方，《千金》、《外台》亦从无发明。特《圣济总录》人参养荣汤论肺热证治，余试之效。若其热盛者，宜秦艽扶羸汤、知母茯苓汤。若腹满者，秦艽鳖甲散加槟榔。盖肺热者，多属不治，肺冷者，反易治，不可不知。

世有咽喉不利，似膈非膈，声音如小儿弄草笛，不能卧，脉数急，忽吐脓血一升余而死者，此肺痈一证最为难治。

奔豚证。桂枝加桂汤主泄气，奔豚汤主和痛。若此证喜苦味者，宜奔豚汤。喜甘味者，宜上方。

四饮中支饮最为可畏，此水饮停积胸膈间，支乘心故也。其初胸膈实痞强支心，心下反濡，咽喉喘逆，气急不能卧者，《圣济》旋复花汤尤效。若此证心下坚硬，水饮支结甚，或与此汤再复者，宜木防己及去石加茯苓硝汤。此二方外余未见其效。(拙轩曰：支饮之证，古人所论不一，或以为心脏痞塞，或以为脾胃有不足，或以为肾气亏乏。予谓不然，凡人心肺之下，有所谓膈膜者，水饮瘀到其间，则上致肺气不利，下致胃气上逆，心下痞坚，是支饮之候也。《巢源》云：水饮过多，停积于胸膈之间，支乘于心，故谓支饮。出方读便解录，为此条注脚。)水肿下利者，为恶候

。先有水气而下利者，宜木防己汤，《外台》所论可征。先下利而后见肿者，属虚劳，为危候。脚气肿下利者，急冲心而死。故水肿证概主利水而禁下药，若服利水药下利者，亦为凶兆。

胸痹心痛，当心中及心下痛剧者，吐血而死，余往往视之皆然。

一人卒发心痛，手足厥冷，脉绝欲死，余投赤石脂丸料速愈。

妇人经水不调，小腹冷气属瘀血者，温经汤奇效。经后腹痛者，亦属瘀血，宜滑石散(无尽藏)。若行经中腹痛者，属气滞，宜四乌汤。若经水不调，气滞肥满有蓄血者，宜逍遥散，正气天香汤。若产后瘀血上逆者，辰砂最效。若行经前患头痛者，属饮，宜桂枝、橘皮、干姜等。(《医通》)妊娠五月后堕胎者，概系癖块所为，早制其块，则多保全。先辈不知之徒，与滋补药更无效。(此说原于仲景最有理，惟恐女科专门徒由父祖传，未尝留心古学。而讲求夫通变化裁之活用，固执温补为安胎之要药，受其害者不少。噫。)产前水气微者不足畏。若上部有水气，气急喘逆者，产后忽冲心而死。或蓐中有肺血干而吐血者，俱为可畏。又有产后汤浴感湿，邪为脚气肿者，不早治则为不测之变。

黄胆烦渴吐逆腹胀者，为恶证。若夜不得眠，烦躁热渴者，不出二三日而死。

腹中有癖块，而一身发黄者，名曰癖黄胆，亦难治。

病者初脉沉数，忽变缓，似病解，而其人气郁，默默欲卧，身重食不进，小便如汁者，即发阴黄之候也。

虚人疟热与劳热为易混，但疟脉弦大而不数，劳脉数而不弦大，是为别。

虚人截疟以灸大椎为最，其法明旦三壮，午时三壮，将发时三壮。

疟病内热炽盛，频渴饮水，发露当风取凉，邪气不能发泄者，变为水肿，宜越婢加术汤。余尝治此证，水气除而后再发疟，是其征也。

霍乱发振寒者，阳气复之候为佳兆。若虚人不堪振栗者，宜四逆汤。

卒然发呕吐者，有霍乱，有卒中风，其证相同。但中风吐后脉缓而不紧，手足不厥冷，呕吐中能左右手足动摇，吐止半身不遂昏睡，是为别矣。

世医漫认足肿为脚气，特不知脚气以疼痛或挛急或懈怠或麻痹为征，不啻水气也。盖此病湿气胜则肿满，风气胜则不仁。有病在腹而后及足者，有在足而后及腹者，

脉忌洪紧弦而不忌数。心下及人迎动高者，最在所忌也。

余治脚气，先辨表里为治标，以肿满麻痹腰脚痿弱为表证，以发汗解毒为主；以风热炽盛，动气甚，气急腹满呕吐，为里证，以降气利水为主。世医动以表证为危笃，以里证为轻易，治方乖错，生不测之变不鲜。

蛔虫有寒热之分。永田德本以太乙丸治热证虫积，以木香丸治冷证虫积为得。凡郁热盛于膈间，则必为蛔动，医概为蛔厥治之，误矣。(胃热吐蛔，吴又可既论之而无效的治。陈治曰：温热病而吐蛔者，此胃热也。胃虚有热，虫随热气上行，亦吐出也，宜犀角黄连汤。伤寒辨注清中安蛔汤，治胃实热，呕吐长虫，亦为其合治。秋吉质曰：吐死蛔者属热，吐活蛔者多属胃寒。死蛔色白，活蛔微红色，是说似理而不可必矣。)痢疾不论下利多少，以热之轻重为治法之标准。故先以调中汤(《外台》)，发汗后参用大柴胡汤、芍药汤和解。若谵语舌燥黑，赤白脓血下重甚者，以大承气汤、槟榔顺气汤下之，其热解则利自止也。

噤口痢虚烦，宜竹叶石膏汤。《百一选方》人参、黄连、陈皮、莲肉四味者亦佳。此证发逆者不治。

休息痢但下白滞者，宜真武汤加赤石脂。

张子和曰：凡头疮发肿疡处，水气必凑焉，故宜下剂。余本其说头疮加苍术，即为去其水气也。其实者，用牵牛子能奏效。亦同旨。

《金匱》泻心汤云：心气不足吐血，衄血，其主治茫乎无据。按本草百病主治大黄条曰：下瘀血血闷，心气不足，吐血衄血，胸胁刺痛胀，同黄连、黄芩煎服。余据此说治吐血衄血胸胁刺痛者，百无一失也。

凡下齿痛者，灸肩井即效。肩井者，系阳明经之所行也。又奥齿下龈肿者刺之，血出则愈。盖血气妄行，聚于齿龈之所尽故也。

骨槽风证详见《外科正宗》，此疮生于耳前颊骨，而腐溃穿孔，口中喷脓。其初欲发时，或为口眼

斜，后至上龈腐溃，不能饮食，遂有至死者。若因霉毒为此形状者，去其毒则愈。

骨槽初起者，宜医通茵陈散。(茵陈、荆芥、薄荷、连翘、麻黄、升麻、羌活、僵蚕、细辛、大黄、黑丑，以上十一味。)其人无咳，唯语声不出者，宜《外台》茯苓安神汤。平素嗜茶者，多发此证。盖有治不治之别，属上焦虚冷者，多不治。若上焦虚寒，语声不出者，宜《外台》黄理中汤。若咽喉肿或痒，咳嗽声不出者，宜圣济黄汤。

后世中外别设中暑名者，误矣。中暑及中热，皆一病，非别因。东垣不知之以动而得为中，以静而得为中暑，制清暑益气汤者，非矣。又世论古方者，谓伤寒外无中，亦益非矣。《汉书·武帝纪》云：夏大旱，民多死，其来既在仲景前。且夏月身热汗出，恶寒咽干，身重疼痛者，与仲景中门白虎汤，则其效宛如溉水于炭火。又夏月卧寐中感冷气，恶寒发热身体疼痛者，随伤寒治法，与桂枝麻黄则霍然而愈。此二者，岂可混焉哉。

后世以霍乱一证为止夏月者误矣，凡有吐泻而挥霍撩乱者，四时俱有，《外台》、《儒门事亲》可征焉。盖此证夏月多而冬月少者，冬时阳在内而温，夏时阳气走表，阴在内而冷，加之贪冷冻饮料冷食，故多发此证。其状似伤食伤滞，然伤食伤滞者，腹满痛而吐泻如倾，则明日霍然而愈。至霍乱则虽既吐泻，腹痛不止，反发热身疼痛，剧者手足厥冷，烦闷燥渴。此证四时俱有，而夏月者尤重，故世或以霍乱为中暑，益误矣。

凡霍乱心下痛者必吐，脐下痛者必下利。

理，治也。中者，指中焦胃气而言。乃胃中虚冷，水谷不化，变乱吐下，譬之乱线，渐理可治，故名理中丸。建，健也，即健胃中之意，故名建中汤。其义颇异，世医不知之，合为一方，名建理汤。非古意也。

半夏泻心汤，泻心下痞满也，后医以为泻心火，概治痢证，大误矣。

骨空论曰：冲脉之为病也，气逆里急。凡冲脉不足而血燥，故鸠尾下痞满，或气上逆胸中，腹皮如贴背，为心悬痛者，谓之胸痹，故桂枝枳实生姜汤、枳实薤白桂枝汤之所治，皆邪客于冲脉也。

心下动悸有三道：一为寒气客于冲脉，支冲任而悸者，炙甘草汤、大建中汤所治是也；一为因水饮而悸者，桂枝茯苓白术甘草汤、真武汤所治是也；一为有毒悸者，脚气冲逆是也。

凡狂痫证，狂走不安静者易治，唯妄言笑语者，即癫也，又名失心风，难治，《素问》论阳痫阴痫为可据。《本事方》茯苓散、宁志膏、狂气丸，皆阴阳通治方也。夜不得眠者，宜《准绳》灵苑辰砂散。又吐唾不止者，宜局方养正丹。阳痫者，宜灌水。其证剧者，大桶蓄水，乘病患不意，一时可灌沐。其实者，浴瀑水亦佳。是皆降阳气上升故也。

世称流注者，自胸至小腹腰间手足流转，甚则生块，其形平塌漫肿，以手抚之，不坚而肉底有块，其块溃则脓汁出，一块愈，一块又随发，重者至生三四块，终不治

矣。此证发胸以上者，为湿痰流注；发胸以下者，为瘀血流注。发胸以上或手足者易治，发小腹或腰边者难治。瘀血流注者，将发其块，则腰脚难屈伸，微热。有发作急者，不出一月而死，缓者延半年或一年而死。其块将溃时寒热特甚，不可妄与败毒散、小柴胡汤等寒冷药。陈氏用木香流气饮，然此证多属虚，其初宜益气养荣汤。虚急者，宜十全大补汤。又流注发小腹者，疑似肠痈。盖流注属虚，肠痈属实。故治法有补泻之别，不可混焉。

肺痈之为病，其气塞不通，热聚于肺中而致脓溃也。《金匱》所谓口中辟辟燥咳，则胸中阴阴痛者，尤为的证。当早辨知之，临其未吐脓前施之。治若失期，则不可救。其初寒热往来，咳逆脓臭，短气不能侧卧，胸中痛，咽喉不利，呼吸宛如吹笛，是有物碍肺管故也，其脉滑实而数，未吐脓血，时咳，则有如嗅瓶中腐水之臭气。病久者，其臭满一室，终吐脓血而死。吐脓血则如吹笛者忽止，即碍滞肺管者去也。古人试脓法，投水沉者为脓，浮者为痰。今视之痰唯粘稠而已，至脓如炼葛粉，不可切断，是为辨矣。

支饮之为痞，古人以为心藏痞塞，或为脾胃虚弱，或为肾气不足，其说不一。余熟考之，心肺下有膈膜，其形如薄绢，横覆心肺，水饮支乘于此处，则上使肺气不利，喘急烦满，下使胃气逆，至心下痞坚，是为支饮之候。《病源候论》云：水饮过多，停积于胸膈之间，支乘于心，故曰支饮是也。其脉弦紧或沉紧，至夜半后，则必气急促迫极甚，其证疑似喘哮然。

喘哮者，胸中不利之所为，故唯觉咽如塞而已。支饮者，其初有胸痛而发喘，或手足厥冷不得卧，必面部及腹中四肢为微肿，或气急后有大浮肿者，其状虽似水肿之气急。水肿者，初无气急，渐至肿满而气急。支饮者，初为气急而渐至为肿，是为其别矣。治支饮法，以禁食为第一，严忌油腻辣酱等。若肿甚者，要断盐，其法同水肿。又支饮似悬饮，而痛剧者，可以控喘丹下之，又与木防己汤。水气益甚气急者，可兼用甘遂末。若气急甚，呕逆者，宜甘遂半夏汤。与此等方一旦虽得效，再发者难治。凡此证经一二年不愈者，不可妄攻，攻之则速虚虚之害。若实者，有因攻击脱死者。此病近世极伙，当悉意而治之。

白虎风始见于《圣济总录》。其证自肩端连头脑痛如啮，至夜半后，则其痛益甚而无肿气者也。凡痛至夜半后甚者，阴气凝结故也。又有白虎历节风相似而少异，历节者，散见诸书，风湿共通称之谓，有热而骨节痛者。白虎者，谓无热，但阴气凝结而痛者。又有痛风者，谓有肿而痛，与此证自异。白虎风宜《圣济》羌活汤，兼用《本事方》麝香圆亦可，若与此方不知者，可与《金匱》乌头汤。

脚气说以《巢源》及《千金》、《外台》为确，《外台》中苏恭说最可据。

肺胀为病，与肺痿肺痈自异。盖斥肺叶怒张而言，其证咳而上气，有喘而气急。其

状似支饮，然支饮之喘，其初有胸痛，或手足厥冷，气急不能侧卧。肺胀者，热势甚。上气卒发，目如脱，面部下部共浮肿而不至，难侧卧，是为其分也，其说详见于金匱要略。

脚气，精神恍惚，发妄语，热甚有肿，上冲头面而赤，惊悸者，世医认为痢证疗之，非也。凡大病见痢之形状者，多至死。此非真痢证，《素问》所谓六经尽证也。

痢本因水气与瘀血，为痛之病也。余故于大黄牡丹汤，取牡丹皮、大黄、桃仁于牡丹五等散，取桂枝于无忧散，取牵牛子、木通于四乌汤，乌沉汤取乌药又加延胡索一味，立为一方，以治脐下及脚挛急，阴囊肿或痛，或妇人引腰而痛，或痛引阴门，或阴hu突出者，莫不有效矣。(世所谓福井八味痢气方是也。)脾劳证心下痞，腹中雷鸣，无痛而下利，利后心下不快，反痞胀者，半夏泻心汤主之。若脾劳下利而腹痛无热，心下有水气而咳，或下部有水气，腹痛下利者，真武汤主之，此方亦用五更泻效。

钱氏白术散治脾瘕。脾瘕多属虚，消渴病中多兼此证，食物偏觉甘者也。

下血多属脾劳，而脾劳下血忌妄止血，是古所谓肠风属也，宜赤小豆当归散。若动悸甚下血者，宜香艾汤。若牵挛下焦者，宜铁刷汤。此诸汤非止血剂，而下血自治也。(香艾汤、艾叶、香附子、甘草、生姜四味，系福井氏家方，铁刷汤出《局方》。)凡失精者，多因下焦冷而起，故以汤火温腰，且每夜临卧灸三阴交，则免其患矣。

古以失精属虚证，今视不必然。实者间有之，其人过食，则往往为此证，故以节饮食为第一也。(按远行者，往往患之，亦同一般。又屡失精者，屈两脚而卧，则免此患。)羚羊角治下血，其效优于犀角。犀角所主，多在吐血衄血。

后世吐血用升麻，下血用黄芩，一偏见也。升麻亦治下血，故《千金》云：无犀角，以升麻代之。

阴毒病发于阴经，阳毒病发于阳经，故异名而已。朱肱以阴毒手足冷为阴寒盛者，用乌头、附子类，误矣。王安道辨之是也。此病《医宗金鉴》以为今痧病，似可从。

天泡者，为火烁疮，酷暑时发细疹，其色正赤，其初自胁下至肩背痛如针刺而后发触衣被则痛益甚。后皆为水泡也，用解毒泻心汤，与荆防败毒散亦佳。

卷下

高端枳园

枳园名经宣，字子顺，高端氏。文化、方政之间，以医鸣于京师。救济之泽，洽于一时。致仕之后，隐于鹰峰，优游自养，卒年七十有三。枳园生于枫亭、台州、东郭诸人之后，治术融会，颇有机警，所着《医谱》、《方谱》、《药谱》、《认证录》等，足以窥其一斑，今录一二，以备省觉。其他三角、小林竹中、有持诸人，亦声誉相踵，而余未能详之，故期他日云。

诊病有四因、六证、十二候、三诊、七视。四因者，谓外因、内因、内外别因、内外合因。

六证者，谓初、中、终、顺、险、逆。十二候者，谓寒、热、虚、实、浅、深、缓、急、平、间、常、变。三诊者，谓持脉、按腹、审禀。七视者，谓问原、寻证、望色、观形、听声、嗅气、谛习。盖此五法三十二则，乃和汉往圣先贤之遗训，而吾门之所历验。苟审诊视察病源证候者，不可不精究焉。

瘟疫初起，食不减，味不变，精神爽慧，起居如故者，必至热解。食将进时食反减，或绝谷元气衰弱者，间有之，与轻疫食不减者不可混。凡瘟疫自初起至热解，食不进者，不足深虑也。

其人卒然晕倒，不省人事，醒后精神恍惚，或两脚痿弱不能起，尔后身体灼热，口舌干燥，时时谵语，或言语错谬，自汗出，痰喘壅盛而烦躁，其状如中风，半身不遂。或下利呕逆，或哕逆。或四肢微冷者，医不知而为风治之，误也。是瘟疫病热剧，直传于里，元气衰弱之所致。虚禀者及老人多患之，选用柴胡润燥汤、柴胡栝蒌汤。若痰喘者，宜蒌贝养荣汤，然多属不治。

瘟疫淹缠不解，或邪气沉沦，遽然变为脚气者，属危候。

瘟疫初起，手指微抽着，后必发病，多难治。

伤寒、瘟疫、疟痢、霍乱瘥后，有发脚气者，或有病不解变成脚气者，世医不知，而为病后水气治之，遂至冲心而死，不可不慎焉。

产后脚气，四肢产痹软弱，难起居，心中烦悸，腹中不仁，体常烦热，或洪肿或微肿，或肿胀，筋脉弩，或羸筋脉挛急，小便不通，脉紧有力者，宜犀角麻黄汤。医不知而见其头疼、冲气、恶露少等证，为血气之所为，与调血剂者，误也。

风肿之为病，在上则耳后项际，在中则胸膺肩背，在下则腿股胫。流注为肿，其状如痛，或壅或漫，或痛或不痛，或消散，或溃脓，其初见憎寒壮热，头疼体痛等表

证也。风肿在耳后项际者，大则如栳子，小则似梨子。而见前表证者，宜荆芥败毒散。

风肿初起，不辨伤风时气者，见憎寒壮热，头疼体痛，而有表证解后发者，或有表证中见肿胀而热随解者，或有寒热发作有时如疟状，或有身热无间断，其状似温病者，俱皆自初为肿，而至其变，或未为肿，或有表证绝无，而但为肿也。

麻疹初起自汗出者，邪从汗而解。呕吐者，邪从上焦而解。吐泻兼发者，邪从上下二焦而解。鼻衄者，邪从血而解。皆麻疹之佳兆也，不可遽与止汗镇兜涩血之剂。疹快发则诸证自愈。

麻疹初起，与排毒、升麻、葛根、解肌、越婢、连翘、凉膈等汤。不发透者，乃为瘟气收束疹毒之所致，与启蕴汤以散瘟气，则必出透也。(按：启蕴汤系高端之家方，柴胡、黄芩、浓朴、半夏、草果、枳实、甘草、生姜，俱八味，盖九味清脾汤变制也。

麻疹已出，其色如丹朱不红活，麻沙混淆不匀净，地界淡红或微黯，发热烦渴，睛多赤络，口臭甚，唇舌干燥或焦裂，躁扰不宁，小便涩少，大便不通者，乃为热毒内伏，燔灼血液之所致。凉血攻毒饮，加犀角、石膏，或兼服独圣散、紫雪等。疹已出，或焦紫，或红斑、壮热如炙，烦渴引饮，小便赤涩，大便秘硬，口气加混，惊狂谵语，烦躁不安者，宜郁金散，服后暂就眠，则精神即爽然。

之为病，上在鸠尾胁肋，中在脐上左右，下在少腹左右，或浮现于上面，或沉着于下底，或支两胁，或侵两胁，其形或圆或椭，或匾或浓，大者如拳球，如盘鳖，小者似卵茄，似梨杓，或坚硬如石，或柔韧如肉，或软虚如绵，或牵挛肩背，或引拘脊臂，或疼痛，或不疼痛，或脐下无力，或腹内觉狭小，脉多沉迟者也。病在少腹，初起小如桃栗，或鸡蛋，或似茄子、梨实，渐长大。久之，其状如怀胎而正圆，或蹲踞不匾长，不成棱。大者充满腹中，宛如南瓜状，在正中，或微倚左右，按之浮凸，或沉着不移。其处无痛，或虽痛亦不剧，月信以时下，或经血过多，其块必膨胀，饮吃谈笑如故。但俯则觉妨碍耳，名曰肠覃。此证难愈。虽不愈，不为大害，或其状如怀胎，经年月则渐减至如初。若当覃始萌时，早服通气松滞之剂，则或可防之，宜乌荅通气散。

解劳、缓二汤之所治，系将为劳之兆。故二方俱腹力虚软者，加人参。微咳者，加贝母、桑白皮。热深者，加地骨皮效。(枳园所自验自古经方，至俗间单方而又出于自制者，居四之一，如缓汤、润肺汤九味柴胡汤之类，今用之屡得效矣。)疝热甚时谵语，或口渴舌燥，或黄胎、或白胎，大便如热痢，小腹拘急，腰臀下迫难忍者，宜融疝散。窘迫重坠甚者，加大黄。疝无触犯之因，卒然小腹坚硬，痛难忍，或从右，或左上抢冲胁，胁气急息迫，手不可近，烦闷扰乱，身热甚似温病，口渴舌

燥，小便不利，大便秘，或呕吐恶心，或时呃逆，从少腹直上冲心下，或下牵阴囊，但坐不能卧，或肚腹膨胀，弹之为声者，名曰冲疝。其证多属热，宜融疝加大黄汤。

婴孩或幼少时颈有结核者，俗称为癆之兆。虽未必然，间亦有之，不可不知。(按：金匱·虚劳篇》云：肠鸣马刀侠瘦者，皆为劳得之。古人以颈核为劳，是其一征。)虚劳初起，腹肚胀满坚硬而痛，或引少腹咳嗽，盗汗有微热，食了腹乍膨闷，或食不进，大便多泻，甚者日四五行，或时下肠垢，下后腹中稍觉快，若不下，则胀益坚实，而短气烦闷，颈脉甚动，或口咽干燥欲呕，或四肢微肿，而趺上丰满，或喉间微响，时鼻扇，或腹肚疼痛难忍，身体疲困者，吾门谓之腹胀劳。而素有癖而发劳者，多属不治。若与柴平汤、柴胡槟榔汤，大便渐硬，腹胀随减，痛止热退者，为佳兆，此证在虚劳颇为逆候，世医不知，而漫认为胀满，大误也。

伤寒桂枝证兼呕吐者，多因停饮拒格微邪。故治停饮则邪从解，是以不与桂枝汤而与和解汤也。

发散剂加气药，则其效反捷，此气道疏而邪自祛也。如大邪非此例。(家君于二陈汤加葛根、羌活、桔梗，治轻浅风寒，即此意。按丰公征韩之役，人多得外感，医投以不换金正气散无效。鬼将军部下有老医，与以香苏散立验。人问其故。曰：远征人多兼气郁，非气剂则不能达焉。北山寿安曰：近来医家唯以香苏散治感冒时气，气滞头痛痞满，脚气皱脚等，而不言能解食毒之功，亦阙典也。皆与此条相发宜参考焉。)温病里证悉具，而舌上白胎滑者，认为脏结，不可失下，能审他证具而可下之。平素大便秘涩者，得温病忽粘滑，或溏，此非因胃虚邪气猖獗之所使，缓漫失下，则胃气消烁，噬脐无及。

人方汤浴时，身如被束缚，或如灌冷水者，肌表有热也。

《千金方》以浮为表脉，以沉为里脉，而医家奉为典型。余质之于实际，浮有病散脱之候，沉有病收闭之候，而此二脉阴阳俱有之，概不可为表里。

夏月因暑热遗尿者，宜白虎加人参汤。(按：或云三阳合病条遗尿二字，疑当在发汗则谵语下。此说似有理，然有间属实者，宜于实际而征焉。)有人临卧时肩背如负千斤重，渐及通身，须臾冷汗淋漓，烦悸难堪，而其苦顿止者，发中风或支饮之兆也。

风病昏绝，须臾醒又发者，为难治。

中风醒后，诸证稍缓，但肩接骨分离不遂者，为难治。若分离不甚者，间得痊。脚气无手足麻痹、软弱、肿胀、筋挛等，唯心下微急，小腹不仁，食如常。食已短气

，卧则气息稍平，其人上体丰满，下部削小者，此欲上冲之候，不可忽视。

干脚气声嘎咽中痰壅者，多死。

支饮、脚气、产后血气三病，其证大同，而其源大异，不可混治，宜以脉辨之。脉大按之虚无力者，支饮也。脉洪数按之紧有力者，脚气也。脉软弱而数，按之中止者，产后血气也。

(按：此三病本不同，证亦有所区别，宜审焉。)肺痿咳嗽吐沫颇已，其人忽吐血发热者，为恶候。

久咳不止，唾血引红线，或为点斑者，属肺损，虽外候似轻，最为难治。余为制一方，即于桔梗汤方中加白芨、桑白皮，名白芨汤。

虚劳吐红不一，有痰中引血缕者，有痰中为粒颗者，其大或如蚕豆，或如赤豆、绿豆，见血虽小，不可忽诸。

久咳唾血如红缕，或为点斑者，此属肺损，他证虽微，终至难治，早可与白芨汤。世所谓不食病，即《医级》所载神仙劳之类。此证妇人尤多，男子至少。或馋嗜焦饼豆糕，或喜食果瓜、生菜、昆布、海苔。其甚者，绝谷粒，唯饮水，而肌肉润泽，卧起步动如常，小便能利，大便秘涩，口干贪饮，以至年余，其病多出于郁气，故宜气剂而不宜补住也。

人无故饮食减少者，将发大患之兆，当摄养。若缓漫失期，则药餌灸无及。盖此证有暴渐之别，暴减者可治，渐减者难治。一种有神仙劳者，虽不食，与此证自异。

哮喘脉数属阴虚火动者，宜滋阴降火汤。若里邪实，大便不通，脉实者，宜承气汤。

幼时患哮喘者，一旦治之后，有发癫痫或心风者，又有痢疾者，皆系先天遗毒，故为难治。

幼少时患哮喘者，治之后，多变癫、痫、狂、心风四病，或有不服药自变此四病者，又有初患痢，治后变哮喘者，又有幼少无事，壮岁始患此五病者，俱系先天遗毒。但因其人体气有迟速耳，吾门皆名之曰胎病。(胎病名出于《素问·奇病论》，可以征焉。)风痰家时发热恶寒头痛，身体疼痛，或肩背强急，或咽喉签痛者，皆痰之所为，非感冒也，俗名曰痰风。

胸痹痛在皮肉间者，为恶候。

背胛或右或左拘痛，动摇则益剧，而其痛骤去者，多变为胸痛。状与胸痹相似，而筋脉纠戾之所致。故气急妨闷，饮食微噎。其痛亦与胸痹彻痛不同也，宜《本事方》桂心散。

哕逆与热药无效者，属壅热，以泻心汤、麻沸汤，服则速愈。(按：《万病回春》以黄连解毒汤、白虎汤，治伤寒热证。医者误用姜桂等药，助起火邪，痰火相搏而呃逆，即同旨。)其人食味皆苦，或甘醋或酸涩者，将发噎之候，但觉苦者为易治。

打扑伤损，瘀血不去，历年后卒然气急，心下逆抢，或昏冒不知人，或妄语，或健忘者，是即瘀血作风状者。

水肿遍身满肿，唯两手肉脱而枯柴者，为不治。

妇人手足麻痹者，多七情郁结，经络凝滞之所致也。正气天香汤，或香苏散、二陈汤相合加乌药。

妇人素郁闷，pin户觉痛痒，时水液渗出，饮食少思，肢体倦怠者，宜加味归脾汤。心中失血养，则必为怔忡，故治此证宜选用四物、八珍、十补、人参、养荣诸汤，俱加麦门、酸枣仁为佳。

患肠风者，概为气急耳鸣，而偶无之。唯目眩头晕者有之，不可不知。

头晕属实者，宜防风通圣散加菊花。

其人无故梦寐恍惚，语言妄错，两手微颤，颜耳潮红，或时喜笑，或作持握状，剧则为瞪视状，须臾觉悟，爽慧如故。此人多壮实，饮食失宜，七情乖错，因劳动倦怠，热痰壅蔽心窍之所为，名曰心慌。不急治，则必发风痫，至不救。其始发密陀僧丸，而后宜清神汤，加减清神汤。

人值雨湿则必腰痛者，宜渗湿汤、除湿汤类。

人卒然盗汗出而不止，饮食起居如故，气亦爽快，大便自调，小便才少者，是水饮渗溢毛孔之所致。早利其小便则愈，宜茯苓甘草汤，不必须止汗涩收之剂。若小便不利而汗血止者，后必发水肿或下利，不可不知。

耳鸣唯闻鸣钟柝声，而不能闻他声音，欲聋之兆也。

痢疾有跗上或膝盖痛者，可不与历节混。

小儿十岁前后肛门生小虫，数十为群，或数百围如鬼灯状，痛痒难堪者，至弱冠多发劳瘵。

龟胸名恐不的，当称鸡胸似是。盖鸡胸病证在幼稚为疳，在少壮为癰也。

婴儿生七八月无病，至九十月渐肌肉肥胖，时时发热，如外感，或如疟，吐乳青便，顶颅光莹，囟门或填满，或凹陷，睡中微抽者，将发阴癰之兆。庸医不知，认为胎肥，可笑。

儿四五岁，鼻衄血月一次或二三次，每次五六勺，多至数合，其血黯紫而稠粘，或鲜红而稀薄。当其发，必气逆面赤，手足微冷，消谷善饥，大便秘，小便数也。此证有乳癖腹痛后发者，有痘后发者，《千金》竹茹汤方中去芍药、人参、术桂，加麦门冬、黄、梔子、升麻效。(竹茹、甘草、芎、黄芩、当归、麦门冬、梔子、升麻、黄、上九味加茜根佳。)百会边时时如有物冲，或时痛，或泪管无故而喷出者，是将发脑风候。

结毒有胎毒二因，而因毒者十之八，胎仅居其二。其状多属冷毒，而属热者甚少。

露败疮与漏疮同，义通诸疮而言，非一病也。但彼则漏泄，此则闭结，虽其状异，至其不痊一也。

霉毒有冷热之分，不可不详。冷毒尤少，而热毒常多。冷毒属气而痊迟，热毒属血而痊速。

冷毒轻缓似易，热毒剧猛似险。又冷毒面色皓白如常，热毒面色惨黯隐显不定。冷毒生疮多年不痊，而其势不剧甚，热毒则生疮浸淫为激发，是为辨。世医不知，一概治之，误人最伙。(拙轩曰：梅毒分冷热，翁之创见，非经历深者不能也。)流注毒稠脓渐化为稀水者，非佳候。若脓止唯鲜血淋漓者，虽能食神爽，死在近，不可轻忽。此与产后脱血其候同也。(败液流注往往发此证，最为危急候。)

卷下

多纪桂山

桂山先生着书之富，从前医家无比，皆医林鸿宝，一日不可少，犹布帛菽粟。而治疗之盛，年不下七八百人。是以一匕之验，半句之话，亦可以范后生矣。

小野氏乃政年十八，妊娠弥月，胎水渐盛，遍身洪肿，下体尤甚，口舌生疮烂坏，不能啖盐味，日啜稀粥仅一二碗，小便赤涩，大便隔日一解，脉滑数有力。医以为

胃虚不能摄水，与参术等药，势殆危剧，遽邀予理之。予曰：胎水挟湿热者，非胃虚也。投以猪苓汤加车前子、黄连、梔子，盖车前子一名芡苢，不止利小便。亦取毛诗云，宜怀妊之意，服五六日，逐渐小水快利，肿胀稍散，口中亦和，饮啖复常。因改用紫苏和气饮加白术、黄芩。至月尽而诞，母子两全矣。

御药局小吏儿生五个月，吐乳日六七次，无他证，惟面色青白，似稍疲倦。父母忧之，请理于予。予曰：此责在小方脉，敢辞焉。渠曰：凡小方理吐乳，非钱氏白术散、香砂六君子汤，则凉膈散、紫圆之类，其变慢脾者，比比皆是，愿君别为处置，以救豚犬命也。恳请不已，予因制一方以与之。半夏为君，茯苓为臣，藿香、伏龙肝为佐，丁香为使，生姜为引，每帖一钱，水煎，别以养正丹为散，以挖耳头挑散子入口中两麻子许，以前药汁送下，日五次，不浹旬而吐止神色复。故此予常用理翻胃方，借以疗吐乳未足以为奇。而世之哑科徒守常套，而不知此等策，听其夭殇，悲夫！一商家仆年二十岁，患脓淋数日，时时发微寒热，饮食少进。诊之，脉沉小而数，腹中无病，第似神色不太乐者。予以为肝经湿热，与龙胆泻肝汤。后十余日忽走使曰：下血数升，命在须臾。余仓皇往诊，仰卧蓐，气息绵，六脉洪数而虚，急灌独参汤，下咽即吐，寻之干呕，额汗淋漓苦闷，吐蛔七条，试作小半夏加茯苓乌梅蜀椒汤与之，呕逆益甚。余沈思谓孙思邈以单甘草止吐，今用之蛔必安，因如法服之，吐忽止，气息稍平。时看护者将更蓐，除污，披衣视下体，阴囊破坏，有孔如剜，双卵坠在蓐，其大如鸡蛋而稍扁，色白而红缕缠绕，众惊愕报予。予曰：昔江篁南以阴囊破裂为千古稀见，况阴丸脱落者，可谓奇中之奇矣。虽然，人有阉，豕有，此皆割势而犹能生。此人霉毒结于阴囊，故有此变，与坏鼻蜡烛疳亦同，调护得宜，当不死，后调理果愈。

脚气所因，有湿邪中足，壅塞经脉而致者，有肾气不足，饮水失道而致者，有膏粱过度，脾胃湿郁而致者。故预防之法，忌久坐阴湿地，或着滋湿衣，或冒雾而行，或步久雨霁后地气蒸发之处，忌过食鱼鸟饼粢一切浓味，忌大酒及醉睡，忌房事过度，及醉后入房，忌久坐久立，及行步劳动俱失其常。慎此五者，则不止脚气，亦诸病不生，久视之要诀也。

小儿吐乳虽数端，大要不过虚实二途。盖有胎元胃虚，不能消化乳汁以分布下部而吐者，有饮乳过食，结成癖积，拒格新乳而吐者，又有胎毒潜伏于肠胃之间，格拒乳汁，或两者相搏，遂为顽涎，结聚胸膈而吐者。此证特多富贵，而贫贱最少。故治法宜清凉者多，而又有宜温补者，又有不拘攻补从中治消痰化食降气杀虫以奏效者，当审其证而治之。

虚劳及极虚证。间有手指末节以下肿黑者，盖经脉不能盈四末，而瘀血败恶之所致，未知前人言及否。

余曾闻之于太田隆元水肿并脚气心下痞硬者，有辨冲心与痞之诀。其痞浮显，按之

易知者，无冲冲之患。其痞沉着，按之难认者，反生不测之变。宜潜心辨之。

久病不问何证，胁肋露歧骨如皱襞者，得生少。

仲景曰：少阴病，脉微细，但欲寐，此少阴邪深入里，阳气衰竭故也。不止伤寒，诸久病语话饮食之际亦眠者，死候也。

《证治要诀》曰：诸中风忽吐出紫黑色者死。验之于诸病皆然，不止中风也。

医者对病患未诊之前，问其证候，胸中预拟其方。则诊毕后反失其真谛，宜虚心精诊，而后熟虑下按矣。

俗所谓疝泻、疝痢、疝淋者，医书所谓气泻、气痢、气淋是也。

欲识古人临证施治之妙，莫如善读其治验。予将掇其精英，类为一书，而年老未果，哀矣。(读前辈成案，可拓后学之心胸。扩群医之见解，第变通则在善学耳。)月信痛，用桃核承气汤加附子效。盖本诸喻氏《寓意草》治伤寒后腰痛按。(一说云柳所发明。)木乃伊芳、血竭二味，等分为丸，能治干血劳。盖木乃伊芳活达瘀血，振兴真元故然。

半夏浓朴汤加浮石，以治梅核气奇效。

麻疹余热不解者，宜柴胡四物汤。(

庭曰：疹后大抵主清润。故宜此方。)诸大患卒发呕者，多不治，如脚气冲心最然。

今时称淋者，多属霉毒，《疮疡经验全书》所谓内注下疳，(用小柴胡加龙胆、车前子者。)《证治要诀》所谓小便注杆甘疮类也，不可与古淋混治。(东郭亦有此说，而考证未确。)一奴隶患手大指触物，则气宇郁塞，不可名状，诸治无效。余以为血气流注，与活络流气饮速愈。

《痰火点雪》云：劳疾左胁痛不能转身者，此乃肝叶已干，名为干血痛，肝经已绝，死不治。此说本于《直指方》，而其证今多有之。医误认为肝积，与熊胆等无寸效，宜矣。(山田业广曰：《素问·刺禁论》肝生于左，肺藏于右。其所谓生者，言生长其气于左。凡《素问》中言，生者皆同，言左者，非言位置，肺藏于右亦然。验之于实际，病在左者，宜疏肝泻肝，可以见也。)《祝氏心医集》云：疟疾每日如期而至，名曰疟信。此当原证发散，未可直攻，未可截也。或前或后，此正气渐旺，邪将不容，名曰疟衰。方可截之试之甚理。

痢疾似虚而不虚，似实而不实者，用参归芍药汤，兼聂氏治痢第三方，米糊为丸，

白汤送下。

俗所传奇方者，多出于本草附方，不可不读。

水户侯(文公)有疾，其初登圉大便不快下，胸满短气，如此两三日，或发或瘥，乃召余诊之。其脉滑数无根底，面色青惨，心下微满而拘急，腹里无动，脐下空软如绵，乃知其病上盛下虚，非一日之故也。但侍臣视其起居如平，无能察知病情者。余出语之曰：侯病虽似支饮，实由中气虚耗，殆为危证，治法宜峻补方中加沉香，更进黑锡丹以回阳镇逆，犹恐不及也。侍臣闻之，或惊惶，或疑惑，不知所为。明日诊之，间吐痰沫，其色茶褐色。厥明又诊之，脉十动一止，因谓侍臣曰：此证此脉，俱为脏气竭绝之候，恐有急变也，须灸天枢、气海、三里、绝骨等以培下元。医不信，逡巡进降气之剂，而次日晡将登圉，短气息迫，卒然昏倒，急使人召余，至则绝矣。余叹曰：侯之疾纵属不治，使侍臣早见其机，医察其微，则未遽有今日之变也。

卷下

多纪庭

夫医者，必取熔医书而后识见正，必参酌经方而后手段精，必广疗疾而后运用极。故不明医经经方之旨者，虽业大行，侥幸不足观。明医经经方之旨者，虽一匙半剂，亦具有规则。

如庭先生以名家子弟，加之学术兼至，是以超逸前辈泰斗于一世。古人所谓读仲景书用仲景之法，然未尝守仲景之方，乃为得仲景之心者，非耶。

文化丙子夏秋之交，江户大疫，其证初起热势猖獗，直进于少阳，不日至精神昏愤，大概宜大小柴胡汤，黄连解毒汤。而及于阳明胃实者至少，尔后流行往往类此，而如阴证甚鲜矣。

余尝视先教谕治伤寒多用参附，故老亦言先生多阴证躁扰者，噫风气变迁所使耶。(疫因岁运有变替，亦见于工藤周庵救瘟袖历，及荻野台州瘟疫辨。盖辨六气之环转，拆神气之出入，阴阳消长之妙，虚实递更之变，首尾贯通者，唯仲师书为尔，后学当细心辨之。)辛巳岁，春来多旱，至夏秋之际，炎热特甚，疫邪流行，其证不恶寒，肌热如灼，脉洪数或紧细，手腕颤掉，下利日四五行，或溏泄过多，渴好冷水，舌上无胎而干燥，心下支结，腹虚满雷鸣，谵语，或昏睡不语，吐沫头汗，甚者呕逆上窜，速羸瘦，下黑血，遂死。余以为是暑热侵肌肉，邪气着筋脉，津液干枯，血分沸乱，故至下血而极矣，治法清润补三法中兼利水而得效。盖比之于丙子之疫疾，其证候亦少异矣。

少阴病轻证有既济汤，与姜附益气汤之别。上焦津液干枯，其证似白虎汤而脉浮数无根，脚腹部软弱，且微利，虽渴无欲饮水数升之势者，为既济汤。若夫邪气缓慢，渐见谵语烦躁，肌热不甚，舌上濡润，所谓劳役感寒者，为姜附益气汤。此证三十年前多见之，而至近时唯见导赤各半汤、升阳散火汤等证，而此证绝少。时世之变，亦可以知已。

冬月伤寒发汗不解，下利数行，或不下利，三四日后热弥炽，谵语烦闷，口舌干燥，呼吸促迫，脉弦涩或滑数，无根底，舌上黄润，心下痞，小腹无力，面赤耳聋。余以为直中证，与以附子剂无效。后谓上热下冷，与干姜芩连人参汤，其效如桴鼓。

文政己卯仲夏至仲秋，都下痢疾大行，毙者不知数。其证皆热毒痢，邪气炽盛，下利至百余行。治法发表攻里，或清凉奏效，而偶有挟虚者，桃花汤所宜，若误投粟壳、诃子类必害。

又虚家屡下之后，血水泄下羸脱者，又腹里拘急，至夜燥渴，用地黄得效。

痢疾久不愈，舌上如粟粒，其色黄白或纯红，甚者及牙，此证多属不治。又有舌上咽喉牙一面生浓黄白胎如鹅口者，有发吃逆者，皆为不治。(按：诸久不愈，口舌生鹅口疮者，皆胃气衰败之候，固为死证。)痢疾发渴者，多好热汤，不可概为阴，而治寒下剂间效。又痢疾手指逆冷者，属热，阳脱于上故也。又热痢失下虚极者，必手指冷至肩上，而足仅过踝而已，俱非温药，所宜矣。

痢疾初起，脉数无伦，下利频数，精神不安，额上汗出，面部肉脱者皆为不治。

文政庚辰春夏之交，淫雨数日，霁后暴催溽暑。时人发奇疾，其证如干霍乱，心腹卒痛暴热，脉洪大，心下支结，饮食不进，大便秘结。因与备急圆、大陷胸汤类，则反痛甚，热不去，徒生烦渴。余以为雨湿内郁，毒瓦斯上攻者，试与增损理中丸料，(代白术以苍术。)痛顿减，不日快复，遂活数人。后阅东郭导水琐言，京师亦行此证，东郭用外台桑白皮、吴茱萸二味者得效，盖一类也。(按：桑白皮、吴茱萸二味方，原治急喘，而东郭运用之，元和纪用经名之降气汤。)痘疹发热疑似者，诊虚里，其动亢盛及缺盆者，痘也。此动无者，他病也。余得此诀于小川桧斋，而验之果然。

霉毒虽分四证，不出二端，何则？下疳在肌肉而毒浅，故发则为杨梅疮，便毒着筋脉而毒深，故潜则为结毒。然亦有虚实之分，下疳其人虚者，毒易侵入。故其愈迟便毒其人实者，毒易外托。故其愈速，竟亦不出二端焉。

旧疾暴变者，多因邪气内伏。能认其候，不拘本病，直与发散剂则效，是即先治其

卒病之意。

和田东郭以地黄治心下痞，盖本诸吴氏参附养荣汤，治下后反痞之说。余以为地黄之痞，与泻心汤之痞相似而异。腹部宗筋急，津液干枯，其势上迫于心下，故以地黄滋润筋脉，则痞自愈。若饮邪并结，心下支满者，非泻心汤不能解。是所以相似而大异也。

世医将证候错杂难名状者，概曰痢证，盖本诸香川氏行余医言云。《先教论》曰：痢本小儿病，在成人当称曰癰。如香川所谓痢证，则大病奇论所说气疾，戴复庵所谓心风为相近。余尝考其病由，系心肝胆三脏，有由心神虚怯，与心气不宁者，有由肝气抑郁，与肝气过亢者。如胆气亦由虚实，证候各异。能读古人论此三脏病证者，则于其治法思过半矣。

难以小便黄白辨寒热。戴复庵既论之，而如以渴之冷热定阴阳，亦不可拘执。热利喜热汤，风湿欲冷冻饮料，同类相求之理，不可不知。其他以所喜冷热定病寒热，大抵为不瘥。

伤寒热剧证，用柴胡、黄芩类，非多服则不能奏效。水气洪肿者，与淡渗药非大剂则不能达方，屡验果然。

呕吐不止，诸治无效者，HT 惟和诊曰：脉浮数，属表邪壅遏，与葛根黄芩黄连汤速愈。又有同证者，片仓周诊曰：脉沉伏属郁热，与白虎汤果止。可谓二子诊异表里而并妙矣。

古方之妙，殆不可思议，今举其二三：如牡蛎泽泻散料，(或加大黄)治实肿阳水；栝蒌瞿麦丸，治肾气丸证而嫌忌地黄者；黄连汤，治霍乱吐泻不止，心腹烦痛者；梔子甘草豉汤，治膈噎食不下者；苓桂甘枣汤，治囊累年不愈，心下痛者；白头翁汤，治肠风下血。余数年所实验，桴鼓影响，妙不可言。用古方者，岂可不精熟哉！(陈修园曰：旋复代赭石汤，今于呕吐不止之证，及哕逆借用甚效者，取其重以降逆也。干姜黄连黄芩汤，今于食入即吐之证取用甚效。又借用麻杏甘石汤，治中暑头痛汗出而喘口渴之外证。黄连阿胶汤，治心烦不得卧之内证。借用麻苧豆汤，育阴利湿，俱从小便而出之类。可知经方之变化如龙也。)囊治方虽居多，无如苓桂甘枣汤者。余又以三因方补脾散炼蜜为膏，服得奇效。若便秘内实者，起废丸为妙。

《千金》紫苏子汤中当归，取之于降气。本草云：主咳逆上气是也。人参败毒散中枳壳，取之于驱风。本草云：主风痒脉痹是也。世医日用而无审其效用者，噫。

余尝治一男子伤寒数日不瘥，谵语面赤，脉紧无力，微下利，上热下冷者，与姜芩连参汤无效，小河雄斋(吉益南涯门人。)与当归四逆汤速愈。曰：予往年患此证，

柴田芸庵用前方得苏矣。

病患足趾甲温而两胫冷者多死，腿胫无水气，但足跗肿者亦危。

大病患忽两颞筋弛如落架风者，属不治。《和剂局方》乌荆圆主治云：头颌宽不收，手盛颌能食。盖此类。

哕逆诸治无效者，与熊胆效，又与左金丸料屡验。

脚气虽小便快利，脉胸动，甚至冲心者，水毒外壅侵内也。又虽脉候胸动俱稳，小便不利，以至冲心者，水毒内郁遏脉动也。此二证系局外之变，不可不精思。

脚气下部无水气，胸背颈间面部或手背浮肿者，忽至冲心，不可轻视。如水肿上盛者亦然。

脚气呕逆喘急者，为冲心之渐，不可忽诸，然复有似而非者。一壮失脚弱胫肿，喘满短气热炽，诊之疫邪挟痰者，乃与柴胡陷胸汤，兼服利水剂亟愈。又一人麻痹痿软，呕逆不食，诊之脚气兼蛔虫者，乃作肾气丸料与之，兼以乌梅丸而全。治此等诊在脉与胸动，而非精诣者难与言。(尝闻先生以一味连翘膏治脚气呕逆冲心者，可谓得古人不传之妙矣。)脚气发热类风寒者，不冲心则为脚痿软，为可惧，救之偏制脚气为妙。若真挟风寒者，非此例，宜比较以辨其差。

诊视之际，有病情隐微难认者二端：一则劳瘵肝郁之类，始萌时感招外邪，外邪虽解，病不可愈者，内为有奸也。若徒为外感治之，则其取败不鲜矣；一则旧疾人得疑似之新病者，假令如痼瘕之得肠，囊之得饮食伤，若拘执旧疾，不治新病，则其害在反睫。此二端最宜精诊熟察。张景岳曰：医有慧心，心在局外，医有慧眼，眼在兆前。其是谓乎？病名古今异称，或一证及数名，极为繁衍。如一病蓄数义，最易致误，今举一二辨之。

肿本痛肿，转为水肿之肿；疮本创夷，转为疮疡之疮；疳本蚀烂之义，而小儿嗜甘为病亦名；疳痰即澹饮，古作淡，而后世概为稠涎之名；瘴，热也，省文作疸，而转为黄病之名，又移为丹毒之名；瘤者，悬赘也，后世转为丹溜之溜；悸，心动也，而古来概为动筑之义；奔豚，难经以为肾积，《伤寒论》以为气冲，咳逆谓咳嗽气逆，而后世谬为哕逆之名；此类宜甄别焉。(桂山先生《瘟疫类编·序》辨病名字义亦精晰，宜与此条参看资益。)近来舶斋医书，大率蹈袭陈言，未有所发明，而其序跋徒极称扬。顾不读古书者之所为，要之优孟衣冠，不过追时习钓名利耳。

读医经与他书异。若读《伤寒论》，最当虚心平气，就其至平至易处，研性命之理，使文义与治术吻合符契，而后博征诸载籍，多验诸疾病，优柔厌饫，浸润涵泳，

真积力久，始足以应变无穷，此之谓善读者矣。世或有穿凿拘泥，固执偏见者，有肤浅浮疏，自夸心得者，有徒鹜论辨，而不察证治之要者，有专拘字训，而不究微意之所在者，此皆不善读之过也。又有不学无术，臆测悬揣，以为得经旨，闻有不合己意者，概谓之后人掺入，妄删改之，此所谓夏虫疑冰，越犬吠雪者耳。盖据经以洞病理，此其常。而亦有由验病而悟经义者，不可不识焉。(医之所贵者，力学之外，又得名师益友。日举其所治之证与圣经之异同，合而讲论，始知其妙。此亦由验病而悟经义之一端也。)尝考诸家注释，成联掇顺文直解，稍属浅拘。然创辟之功诚伟，能为来者所矜式。方中行亦出新裁，非无发挥，然凭其私颠倒经文实作之俑，喻嘉言略本中行，更益端绪，后人何以崇信之。至柯韵伯学识颇高，最有所见，而犹多臆断。程郊倩间话俚语，失解经之体，至论理精密，殆非诸氏所及。汪苓友处心平稳，疏通前注，虽未能脱陋习，固与专己守残，相去悬隔。张隐庵及令韶率由旧本，不敢错易，盖不蹈时趋者。钱天来辨订不遗余力，然或失太凿，亦不无胶柱。《医宗金鉴》汇纂之治，殊为有益，其删章改句，无所不至，抑亦妄矣。(多纪柳曰，古人注张子《伤寒论》者，既无顺文释义之弊，克辟守陋袭胶之说，旨义明了。

别开生面者，柯韵伯《来苏集》是也。割裂旧章以为类纂，虽不免妄改古书之责，错综有条，端绪井然，足以为临局施治之便者，钱天来《溯源集》是也。盖二家之集，精则精矣，奈何博辩冗议，读者不能骤窥其要焉。在泾之书，其说多原于韵伯，其分治法佐天来，而变其例，更出新意以启发之。辞约理该，直截易了，双珠一贯，斯供把玩，是亦活人之手段也。

二子说议论切当，为后学楷则，当与吕沧洲论历代诸医文并传)。读书法务遵古人，古人之言既妥矣，固无须赘说。而徒斗博夸多，更生异见，右傅左会，喋喋费解，谓之无用之辩，吾不取也。

凡读医经遇训义有确据，则举其一二而足矣，不必取于繁冗也。

训诂虽精，而其义不切于治术者，未为得也。训诂虽不精，而施之于疾病必有实效者，乃为得经旨矣。

凡立说者，非通贯全经，则不可谓之尽理蕴，非该尽万理，则不可谓之得经旨，矧乃欲以变律常及拘于常而不通变者，皆善读之过也。讲研轩岐长沙之经，抉择历代良师之着，以切临病处药之际，是吾家为学之方，亦即吾家为医之诀，是以先君子搜罗天下医书以貽子孙，其意一在后之人善读而善用之焉已。(此数条为后学开正路，一一书绅之语。余尝谓自古以来医籍充栋，贤愚不等，偏见迂论者，不可胜数。亦毋庸详辨博考，只验圣经贤传紧要之书，揣摩精究，自然学术自进。锁末字句，置之不论，别风淮雨，何必一一查考耶!)

黄跋

《先哲医话》上下二卷，日本信浓人浅田宗伯撰。考文渊阁着录之书，凡医家类九十七部，一千五百三十九卷。列于存目者，又九十四部，六百八十一卷。证之内服药之气性，方之佐使，无不备也，然未有辑医论以成话者。医之有话，实自宗伯始。夫医者意也，病有万变，医无一定。自《和济局方》专主燥烈香热之品，而刘守真救以寒凉。至于张子和举一切病以汗吐下三法治之，东垣兴而重固脾，丹溪出而重滋阴，景岳作而重补阳。夫古之人，覃精研思，竭毕生之心力以从事。当夫纵心孤往，必熟察夫天时之寒热，地气之燥湿，世运之治乱，人身之强弱。一旦豁然贯通，或补或伐，如良相治国，名将用兵，投之而无不如意。其一偏之论，皆其独得之秘也。或不察所由来，媛媛姝姝，守一先生之说，物而不化，是何异刻舟求剑，以为剑在是乎？至鉴其无效，转谓古方适足以误人。如陈起龙、黄元卿，诋先哲，不遗余力，抑又慎矣。盖先医真积力久，而有所独得。单词短语，皆精微之意，行乎其间，虽涉一偏，学人能优而柔之，厌而饫之，复神而明之，用均无不效。又况其言之纯粹以精者乎？是卷搜罗名言，间附评论，皆折衷精当，托始于后藤艮山。艮山盖唱复古之说者，而末卷多纪庭之论。于读经之审，运用之妙，尤三致意焉。非唯举先哲之法以示人，且示人以效法之方，浅田氏于此得其力勤而用心苦也。日本之知汉医，自新罗百济来，逮隋唐而盛。其后李朱之说大行，丹水友松号倡复古，医学昌明至于今，此书所录。自享元至文政，凡十三人，取其尤着者耳。浅田氏名惟常，号识此，一号栗园，旧幕府医官，今隐居不仕，以医名五大洲。着医书三十余种，斯其一也。顷疗余疾，因得读其书。他日归，将致之医院，以补金匱石室之缺云。

大清光绪五年闰正月岭南黄遵宪公度跋并书

书《先哲医话》后

岁遇丰熟，谷盈百室，露积其梁，而遗秉滞穗，犹且可拾，寡妇所利。较诸农夫所庆，虽有多少之等，岂异其坚栗乎？向栗园公着《皇国名医传》，叙先哲事迹，犹谷盈百室，然虽此篇属遗秉，坚栗则同焉。后进尝其旨否，所利不少，终善且多者，必有矣。因想初公苦学，盖亦不与农耕陇亩，蹈泥淖，驱牛马，耘耔费精而时刻望秋异。今之学富业殷，亦复与农遇丰熟。黄云漠漠表嘉瑞同，吾曹推公为，为仓城，则此刻告竣，其可不庆乎，喜而跋。

今村亮谨识赵云崧着《瓠北诗话》于唐宋明清四代，取十家以为学人之圭臬，从来诗话无出其上者也。

栗园浅田君之着《先哲医话》，体例似瓠北所载十三家，虽儒医异道，其为大家一也。予曾谓我邦文本之事输筹西土，独至医术洵有出蓝之妙也矣。清朝医家尤饮鹤、徐洄溪称为大家，徐氏《医学源流论》议论正大，学力可见。至读《兰台轨范》，则殆如出别手，尤氏《金匱翼》稍可见。《医学读书记》，则甚少可取者，无他，坐文胜而实不足耳。此编之成，使辨发儿读之果何如哉？若有王梅庵其人，则叙而传之也必矣。然则君之此举，可谓补医林一缺事矣。明治己巳晚夏朔。

后学 村山淳拜识赵宋以降，诗话之多，累积可柱屋。而至文话则唯宋有王文话，明有闵文振兰庄文话，李云文话而已，如医话绝无，不亦杏林缺事乎？迺者读诗人征略，引灵芬山馆文钞云。黄凯凤工于医，以济物为急，合善药以施，辑其所得为《医话》。《瘟疫论类编·序》云：刘奎亦着《松峰医话》，而未见其书，每以为憾焉。栗园先生尝仿其目，辑皇朝名哲之说，名曰《先哲医话》。盖医有案有话，医之有案，犹吏之有案，断章取义，有格定之式，而话则优游厌饫，入人心者深。是则不可不与诗文之话并存而传也，因校以授梓。

门人 信浓 松山挺谨识